كلية الطب
و الصيدلة - مراكش

FACULTÉ DE MÉDECINE
ET DE PHARMACIE - MARRAKECH

MARRAKECH
جامعة القاضي عياض
UNIVERSITÉ CADI AYYAD

Guide de Stage

كلية الطب
و الصيدلة - مراكش

FACULTÉ DE MÉDECINE
ET DE PHARMACIE - MARRAKECH

Guide de Stage

Préambule

Le stage hospitalier représente le lieu privilégié où le stagiaire doit acquérir des comportements médicaux au contact de ses aînés dans ce domaine. Il en sera marqué tout au long de sa vie professionnelle. Ainsi, ce stage complétera l'enseignement théorique (cours magistraux, enseignements dirigés, documents personnels) en immergeant le stagiaire dans les conditions réelles de soins donnés au malade. Il s'agit donc de confronter, durant une courte période, la théorie et la pratique. L'enseignement pratique repose avant tout sur le compagnonnage. Le stagiaire apprend au contact de ses pairs plus expérimentés :

- Il assiste aux visites médicales, des médecins et internes du service
- Il assiste aussi à certaines consultations
- Il s'imprègne de l'ambiance hospitalière
- Il tente de comprendre la prise de décision médicale

De manière générale, il est demandé au stagiaire de faire preuve d'initiative, de curiosité et d'intérêt, dans le respect des patients, de l'équipe soignante et de l'encadrement pédagogique. Ainsi, le stagiaire hospitalier a une double obligation :

- Une obligation de formation, qui nécessite assiduité et participation active aux activités pédagogiques organisées pendant le stage.

- Une obligation de participation aux activités cliniques ou médico-techniques spécifiques du service concerné.

Il convient de souligner que le stage doit répondre essentiellement à une finalité pédagogique. En aucun cas, il ne doit être considéré comme un emploi. Ses objectifs s'intègrent dans le projet de formation qui allie connaissances et compétences acquises à l'université et celles à acquérir pendant le stage. Le stage doit être perçu comme le prolongement des études mais également comme une première expérience professionnelle pour l'étudiant.

En prenant conscience du fait que les étudiants d'aujourd'hui seront nos collègues de demain, nous avons souhaité remettre en question notre fonction d'encadrement. S'intéresser à la formation des étudiants implique une réflexion sur les soins réalisés, et sur les possibilités d'en améliorer la qualité. En période de pénurie, encadrer les étudiants constitue aussi un

moyen de recrutement de futurs collègues.

Le présent document a pour but de faciliter votre arrivée dans le service hospitalier et de permettre le bon déroulement de votre stage. Il a pour ambition de favoriser la relation triangulaire Institut - étudiant - terrain de stage.

Nous vous souhaitons la bienvenue et espérons que ce stage répondra à vos attentes.

Enfin, nous remercions le comité du stage hospitalier pour leur participation à l'élaboration de ce guide.

Professeur Mohammed Bouskraoui

Doyen de la Faculté de Médecine et de pharmacie de Marrakech

Sommaire

I- Réglementation des stages hospitaliers : 5
A. Objectifs et organisation des stages 5
B. Nature des stages 7
C. Déroulement des stages 8
II- Services hospitalo-universitaires : 9
III -Fonctions hospitalières de l'étudiant : 17
A. Les obligation de l'étudiant 18
B. Les horaires du stage hospitalier 19
C. Les gardes 19
D. Le congé 20
E. Les rémunérations 20
F. Les sanctions 20
IV- Déroulement des stages hospitaliers 21
V- Nature des stages hospitaliers : 22
A. Le stage de sémiologie - soins infirmiers : 22
B. Le stage d'externat 22
C. Le stage d'externat plein temps 24
D. Le stage interné 25
VI- L'évaluation des stages hospitaliers : 26
A. Rappel des dispositions réglementaires 26
B. Critères et modalités du validation 26
C. L'importance du stage Hospitalier 30
VII- Les objectifs des stages hospitaliers : 31
A. Les Objectifs des stages hospitaliers de la 1 ère et le 2 éme année : 32
B. Les Objectifs des stages hospitaliers de sémiologie soins infirmiers 35
C. Les Objectifs de stages fondamentales en Médecine et chirurgie 37
D. Les Objectifs spécifiques dans le service de médecine 40
E. Les Objectifs spécifiques dans les services de chirurgie 62

F. Les objectifs de stage hospitalier dans les services de l'Enfant 79
G. Les objectifs des stages dans les services de réanimation 85
H. Les objectifs spécifique des stages dans les laboratoires 88
I. Les objectifs spécifique des stages dans les centres de sante 94
J. Annexe 96

I - Réglementation des stages hospitaliers

Selon le règlement intérieur de la faculté de médecine et de pharmacie de Marrakech (FMPM), le déroulement du stage hospitalier doit respecter les closes des articles du chapitre VI (formation pratique).

A – Objectifs et Organisation des Stages :

Article 31 : Les stages hospitaliers sont obligatoires. Ils sont introduits dès la 1ère année des études médicales.

Article 32 : Ils sont destinés à former sur le plan pratique les étudiants en médecine dans les centres hospitaliers universitaires et dans les formations sanitaires agréées dont la liste est fixée par arrêté conjoint du ministère de la santé et du ministre de l'enseignement supérieur.

Article 33 : L'administration met à la disposition des étudiants au début de chaque année par affichage la répartition des groupes de stages, les dates des différents stages et leur nature.

Article 34 : Les étudiants doublant sont astreints aux mêmes stages que les étudiants de la nouvelle promotion, même si ces stages ont été validés.

Article 35 : Avant le début des stages, l'étudiant doit avoir subi les vaccinations obligatoires. Il doit par ailleurs porter une blouse blanche de médecin, propre. Le port du badge de l'externe est obligatoire au cours de l'activité hospitalière.

Article 36 : Le carnet de stages dûment rempli sera exigé lors des examens de synthèse clinique et thérapeutique.

Article 37 : La présence durant le stage est obligatoire, tous les matins du Lundi au Vendredi. Plus de deux absences non justifiées ou des absences justifiées représentant plus de 10% jours ouvrables de la durée de stage, est considéré comme non assidu et donc non admissible pour la validation de son stage.

Article 38 : La validation des stages d'externat se fera au cours d'une délibération, au plus tard une semaine après la fin du stage. Elle repose sur quatre volets : (voir annexe « évaluation du stage »)

- L'assiduité
- L'évaluation du comportement
- La note de validation des objectifs de stage : validation au moins 80% des objectifs.
- La note de l'évaluation de la fin du stage

Article 39 : Les externes n'ont droit qu'à un mois de congé par an (mois d'août).

Le conseil de fac du 24 décembre 2015 a validé les décisions suivantes portant sur le stage hospitalier :

a/ Revalidation de stage hospitalier au mois d'Août

Le conseil de la faculté a soulevé le problème de certains étudiants qui veulent revalider les stages hospitaliers pour leur permettre de passer le concours de l'internat. Pour cette catégorie d'étudiant, le conseil a décidé de pouvoir permettre à ces étudiants de revalider leur stage pendant le mois d'Août sous conditions :

- Formuler cette demande durant la 5ème année au décanat avant le mois de juillet

- Un accord par écrit du chef de service hospitalier qui est responsable de l'encadrement de ce stage à revalider. L'étudiant doit joindre sa demande avec cet accord.

- Un accord du décanat pour permettre au service de scolarité 2éme cycle de programmer ce stage et autoriser au chef de service hospitalier encadrant sa réalisation.

b/ Validation de stage à l'étranger

Dans la politique d'encourager la mobilité de nos étudiants, Il a été soumis aux membres de conseil la possibilité de permettre aux étudiants de la validation un stage hospitalier à l'étranger. Le conseil de fac a décidé de

permettre cette validation sous réserve que :

- Le dossier de demande doit être étudié par le Vice Doyen à la pédagogie cas par cas
- Le stage doit répondre aux objectifs pédagogiques de formation et sans nuire le déroulement des études de l'étudiant ni son évaluation.

B – Nature des stages hospitaliers :

La formation pratique comporte quatre variétés de stages :

1. Un stage d'immersion dans les structures de soins à la 1ére année d'une durée de 3 semaines. Les objectifs du stage sont dans le guide. Une copie de l'évaluation de stage et une copie du rapport de stage doivent être déposées au centre d'accueil 1er cycle à la fin du stage.

2. Un stage de médecine sociale à la 2ème année d'une durée de 3 semaines.
3. Un stage des soins infirmiers et sémiologie au début de la 3éme année
4. Des stages d'externat durant la 3éme,4éme et la 5éme année .

Article 41 : Ces stages se déroulent du 5ème au 10ème semestre des études médicales. Ils durent de 7 à 10 semaines.

Article 42 : Ces stages se déroulent dans les différents services du C.H.U. Mohamed VI de Marrakech et l'hôpital militaire ou dans les services agréés. L'organisation de ces stages se fait sous la responsabilité du comité des stages hospitaliers :

- Stages de 3ème année : sémiologie, médecine, chirurgie.
- Stages de 4ème année : pédiatrie, médecine, chirurgie, biologie
- Stages de 5ème année : gynécologie-obstétrique, médecine, chirurgie, biologie.

Article 43 : Tout stage non validé doit être revalidé dans sa totalité. L'étudiant est réparti par le service de scolarité selon les possibilités d'accueil du service.

5. Un stage d'externat plein temps en 6ème année.

Article 44 : Il dure un an et se déroule durant le 11ème et le 12ème semestre dans les services du centre hospitalier universitaire Mohamed VI ou dans les services non universitaires dirigés par les enseignants de la Faculté, le matin et l'après-midi.

Les étudiants de 6ème année sont tenus à assister aux différents modules de médecine de famille. Des absences non justifiées pourraient affectées la validation du stage hospitalier en cours.

6. Le stage d'internat.

Article 45 : ce stage dure un an et se déroule les 13ème et 14ème semestres des études médicales. Pour accéder à ce stage, l'étudiant doit avoir validé tous les stages antérieurs.

C – Déroulement des stages :

Article 46 : En plus de la participation à la vie active du service, l'étudiant doit acquérir les objectifs nécessaires à la pratique médicale courante ; ces objectifs sont contenus dans la liste spécifique à chaque service remise à l'étudiant au début du stage.

Le carnet de stage est un élément du livret de l'étudiant. Il doit être soigneusement remplit durant toute la durée de l'externat. Il doit être présenté au jury des examens de synthèse clinique et thérapeutique.

Toute falsification expose l'étudiant à des sanctions graves.

II- Services hospitalo-universitaires

Le centre hospitalier universitaire (CHU) de Marrakech ainsi que l'hôpital militaire assurent une triple mission de soins, d'enseignement et de recherche. Il dispose d'un plateau technique performant et dispense des soins hautement spécialisés. L'ensemble des spécialités médicales, chirurgicales, radiologiques et biologiques est au service de la population de la région de Marrakech.

Site Web: http://www.chumarrakech.ma

L'accueil des stagiaires se fait le premier jour du stage à 8 Heure 30 du matin à la salle de cours du service. Le chef de service (ou l'un de ses adjoints) procédera à la présentation du service, sa capacité litière, les casiers des dossiers des malades et les imprimés pour bilan ; il procédera également à la présentation des médecins enseignants, du personnel paramédical, des secrétaires et du major du service. Le chef de service établira la liste de répartition des malades, la liste des présentations à préparer. Il désignera les médecins tuteurs. Enfin, le chef de service présentera les objectifs du stage, les activités d'apprentissage et mettra l'accent sur l'importance du carnet du stage.

Les services de médecine :

Services	Hôpital	Chef De Service Responsable de Service	Enseignants
Pneumo-phtisiologie	Arrazi	Amro Lamyae	Sarhane Hind Sajiai Hafsa Ait batahar Salma
Radiologie	Arrazi	Cherif Idrissi El Ganouni Najat	Ouali Idrissi Mariem
Gastro-Entérologie	Arrazi	Krati khadija	Difaa Azeddine Salmani Zouhour Oubaha Sofia
Médecine interne	Arrazi	Essaadouni Lamiaa	Benjilali Laila Zahlane Mouna
Cardiologie	Arrazi	El Hattaoui Mustapha	El karimi Saloua Benzeroual Dounia
Radiologie	Mère Enfant	Jalal Hicham	Basraoui Dounia
Radiologie	Ibn Tofail	Alj Soumaya	
Neurologie	Arrazi	Kissani Najib	Louhab Nissrine Adali Nawal Chraa Mohamed
Psychiatrie	Ibn Nafis	Asri Fatima	Manoudi Fatiha Adali Imane
Dermatologie	Arrazi	Amal Said	Akhdari Nadia Hocar Ouafa
Endocrinologie et maladies métaboliques	Arrazi	El Ansari Nawal	El Mghari Tabib Ghizlane
Néphrologie	Arrazi	Laouad Inass	Fadili Wafaa
Rhumatologie	Arrazi	El Bouchti Imane	Belkhou Ahlam
Anesthésie réanimation	Arrazi	Samkaoui Med Abdenasser	Ziadi Amra Zerrouki Youssef
Urgences	Ibn tofail	Nejmi Hicham	Abou El Hassan Taoufik
Anesthésie Réanimation Pédiatrique	Mère Enfant	Younous Said	Mouaffak youssef

Radiothérapie Oncologie	Centre oncologie hématologie	Khouchani Mouna	El Omrani Abdelhamid
Maladies infectieuses	Arrazi	Tassi Noura	Ihbibane Fatima
Hématologie clinique	Centre oncologie hématologie	Mahmal Lahoucine	Tazi Mohamed Ilias
Oncologie médicale	Centre oncologie hématologie		Belbaraka Ghizlane
Médecine nucléaire	Centre oncologie hématologie	Matrane Aboubakr	Bssis Mohammed Aziz
Réanimation Médicale	Arrazi	Hachimi Abdelhamid	El Khiyari Mina
Anesthésie réanimation	Ibn Tofail	Khallouki Mohammed	
Anesthésie Réanimation Gyneco-obstétrique	Mére-Enfant	Eladib Ahmed Rhassan	Rebahi Houssam
Reéducation et réabilitation Fonctionnelle			Abdelfettah Younes

Les services de chirurgie :

Services	Hôpital	Chef de Service / Responsable de service	Enseignants
Urologie	Arrazi	Sarf Ismail	Moudouni Said Med Dahami Zakaria Lakmichi Mohamed Amine
Chirurgie Viscérale	Arrazi	Finech Benasser	Louzi Abdelouahed Rabbani Khalid
Traumatologie orthopédie A	Ibn Tofail	Najeb Youssef	El Haoury Hanane Madhar Si Mohamed Chafik Rachid
Traumatologie orthopédie B	Arrazi	Saidi Halim	Abkari Imad Benhima Mohamed Amine
ORL	Arrazi	Raji Abdelaziz	Aderdour Lahcen Nouri Hassan Rochdi Youssef
Chirurgie Maxillo-Faciale	Ibn Tofail	Mansouri Nadia	El Bouihi Mohamed
Ophtalmologie	Arrazi	Moutaouakil Abdeljalil	Baha ali tarik Benhadou Rajaa Hajji Ibtissam
Chirurgie réparatrice et plastique	Arrazi	Ettalbi Saloua	Benchamkha Yassine El Amrani Moulay Driss
Neurochirurgie	Arrazi	Ait Benali Said	Ghannane Houssine Lmejjati Mohamed Laghmari Mehdi
Chirurgie cardio-vasculaire	Arrazi	Boumzebra Drissi	El Houati Rachid Zouizra Zahira
Chirurgie infantile viscérale	Mère Enfant	Oulad Saiad Mohamed	Kamili el ouafi El Aouni Fouraiji Karima
Chirurgie infantile traumatologie	Mère Enfant	El Fezzazi Redouane	Aghoutane El Mouhtadi Salama Tarik
Chirurgie thoracique	Arrazi	Msougar Yassine	
Neurochirurgie	Ibn Tofail	Aniba Khalid	

Chirurgie viscérale	Ibn Tofail	Benelkhaiat Benomar Ridouan	Narjiss Youssef

Les services de pédiatrie :

Service	Hôpital	Chef de Service / Responsable de service	Enseignants
Pédiatrie A	Mère enfant	Bouskraoui Mohammed	Draiss Ghizlane Rada Nourredine
Pédiatrie B	Mère enfant	Sbihi Mohamed	Ait Sab Imane Bourrahouat Aicha
Néonatologie	Mère enfant	Maoulainine Fadl mrabihrabou	El Idrissi Slitine Nadia Bennaoui Fatiha
Urgences pédiatriques	Mère enfant	Bourrous Mounir	
Oncologie pediatrique	Hématologie Oncologie Pédiatrique	Houdzi Jamila	

Les services de gynécologie obstétrique

Service	Hôpital	Chef De Service / Responsable de service	Enseignants
Gynécologie obstétrique A et B	Mère enfant	Soummani Abderraouf	Asmouki Hamid Aboulfalah Abderrahim Ait Benkaddour Yassir Harou Karam Boukhanni Lahcen Bassir Ahlam Fakhir Bouchra

Les services laboratoires

Laboratoire	Hôpital	Chef De Service / Responsable de service	Enseignants
Anatomie Pathologique	Arrazi	Rais Hannane	Belbachir Anas Elhazmiri Fatimzahra Fakhri Anass
Biochimie	Arrazi	Chabaa Laila	Fadil Naima
Recherche clinique	CRC	Amine Mohamed	Adarmouch Latifa
Immunologie	CRC	Admou Brahim	
Microbiologie	Arrazi	Soraa Nabila	Zahlane Kaoutar
Hématologie	Arrazi	Haouach Khalil	
Pharmacologie	CRC	Zaoui Sanaa	
Génétique	CRC	Aboussair Nisrine	

CRC: centre de recherche clinique

Les services de l'hôpital Militaire Avicenne : Services médicaux :

Service	Chef De Service / Responsable de service	Enseignants
Radiologie	EL Fikri abdelghani	Atmane EL Mehdi Mohssine Abdelilah Saouab Rachida
Pneumologie	Bouchentouf Rachid	Benjelloun Amine Janah Hicham
Cardiologie	Khatouri ali	Ben driss Laila Rbaibi Aziz Bouzerda Abdelmajid
Médecine interne	Zyani Mohammed	Qacif hassan Baizri Hicham Elqatni Mohamed

Rhumatologie	Niamane Redouane	Ghazi meryem Ghourzlani Imade
Neurologie	Rafiq Reda	
Anesthésie Réanimation	Zoubir Mohamed	Sedikki Rachid. Qamouss Youssef Aissaoui Younes Alaoui Hassan
Psychiatrie	Benali Abdeslam	Mouhabi Khalid
Médecine Physique et réadaptation fonctionnelle	Arabi Hafid	
Néphrologie		Asserraji Mohammed
Oncologie		Mahfoud Tarek

Services chirurgicaux :

Service	Chef De Service / Responsable de service	Enseignants
Chirurgie viscérale et Thoracique	Achour Abdessamad	Barni Rachid Mejdane Abdelhadi ElKhader Ahmed Zidane Moulay Abdelfettah Lahkim Mohammed Bouchentouf Sidi Mohammed Arsalan Adil
Chirurgie traumato-ortho-pédie	Koulali idrissi Khalid	Mergad Omar Nader Youssef Boukris Jalal
Urologie	Touiti Driss	Moufid Kamal ghoundal omar
Vasculaire	Alaoui Mustapha	
Maxillo-faciale / chirurgie plastique et reconstructrice	Abouchadi Abdeljalil	Lakouichmi Mohamed Tourabi Khalid Abir Badreddine
ORL	Bouity Brahim	Darouassi Youssef Mliha Touati Mohamed
Ophtalmologie	Kriet Mohammed	Mouzari Yassine
Neurochirurgie	Akhddar Ali	

Les laboratoires :(chef de pôle : Pr Chakour Mohamed)

Laboratoire	Chef De Service / Responsable de service	Enseignants
Biochimie	Chellak Saliha	Boukhira Abderrahmane
Hématologie – hémostase	Ait Ameur Mustafa	El Mezouari Mustapha
Microbiologie Virologie	Zouhair Said	Arsalane Lamiae Kamouni Youssef
Parasitologie	Moutaj Redouane	Naoui Hafida

III- Fonctions hospitalières de l'étudiant

Les idées directrices sont au nombre de deux :

- Le stagiaire est en formation
- Le stagiaire est intégré à l'équipe médicale du service

Pendant ce stage, le stagiaire hospitalier fait partie de l'équipe médicale. Il a donc des responsabilités dont certaines lui sont spécifiques et d'autres communes.

- Responsabilités spécifiques :
    - Le stagiaire est chargé de la tenue du dossier des patients qui lui sont attribués. Il rédige l'observation, collige les éléments de suivi clinique et le résultat des investigations complémentaires.
    - Le stagiaire est soumis hiérarchiquement aux autres membres de l'équipe médicale.
    - Le stagiaire doit informer rapidement les membres de l'équipe médicale s'il constate un élément clinique ou biologique pouvant avoir des conséquences graves pour un patient.
- Responsabilités non spécifiques :
    - Vis-à-vis des patients qui lui sont attribués :
        - Il se présente aux parents en expliquant sa place et son rôle dans l'équipe médicale
        - Il est astreint au secret professionnel, plus précisément il est tenu, comme tout le personnel au secret médical et à la discrétion professionnelle, il engage sa responsabilité pénale en cas de non-respect de ces principes
        - Il respecte les procédures de l'information au

patient et à ses parents telles qu'elles lui sont expliquées au début du stage

- Il tient compte du risque nosocomial dans ses pratiques en respectant les principes du lavage des mains et des autres précautions universelles
- Il apprend le respect du patient (son intimité, ses spécificités)

- Vis-à-vis de l'équipe médicale et paramédicale :
  - Il tient compte du rôle propre de chacun tout en participant si besoin aux tâches collectives dans un souci d'optimisation du fonctionnement propre du service
  - Il respecte le travail des autres (infirmière, kinésithérapeute, aide-soignante, secrétaire) et en évite la désorganisation
- Vis-à-vis de lui-même :

Il est attentif aux risques professionnels auxquels il est susceptible d'être exposé (exposition au sang, aux radiations ionisantes, et aux autres risques infectieux). Les règles d'hygiène en vigueur ont pour objectif de protéger les patients de toute contamination nosocomiale, mais aussi le personnel des risques infectieux inhérents à la profession :

- Lavage des mains, respect des mesures d'isolement,
- Port de gants et/ou lunettes et/ou masque lors d'examens complémentaires avec risques de contact biologique (prise de sang, intubation…)
- Élimination du matériel dans un conteneur immédiatement à la fin du soin

A. Les obligations de l'étudiant :

L'étudiant doit avoir deux préoccupations :

- Valider les objectifs du stage hospitalier contenus dans le carnet de stage**.**
- Participer à la vie du service, sous la direction du chef de service et du personnel médical et enseignant.

Cette activité consiste en :

- La rédaction de l'observation médicale qui doit comporter :
- Le recueil des données fournies par l'interrogatoire et l'examen clinique complet du malade, la conclusion clinique et la nature des explorations éventuellement nécessaires, la mise à jour des données cliniques, para cliniques et thérapeutiques.
- La participation aux visites et contre-visites et la présentation des observations ;
- La participation aux activités de diagnostic et aux examens complémentaires : prélèvements biologiques, participation à des explorations fonctionnelles, endoscopies, actes médicaux de pratique courante, sous la surveillance des enseignants, la présence et éventuellement aider aux soins et aux interventions chirurgicales ;
- La surveillance des malades, conjointement avec le personnel médical et paramédical
- L'externe doit manifester son intérêt dans ce domaine en s'occupant des patients qui lui sont confiés, en les interrogeant, en tenant à jours leurs dossiers médicaux et en prenant connaissance aussi des examens complémentaires.

B. Les horaires du stage hospitalier :

Les externes sont soumis au règlement interne des hôpitaux où ils sont affectés. Leur présence dans les services est obligatoire tous les jours.

Le stage des externes débute de 8 h 30 mn à 12 H, et pour les externes plein temps, matin et après-midi.

C. Les gardes :

Les externes sont assujettis aux gardes dans les services où ils sont affectés. Ces gardes sont fixées par le chef de service. Les stagiaires doivent participer aux gardes sous la responsabilité du médecin de garde pour une initiation progressive à la conduite du diagnostic et des premiers éléments d'orientation.

Les malades qui ont posé des problèmes au cours de la garde ainsi que les entrants doivent être présentés au staff le lendemain en présence

d'un sénior. La récupération après une garde n'est pas systématique. Elle est décidée en fonction des besoins du service et après avis du chef de service.

L'étudiant est responsable de sa garde. S'il est dans l'impossibilité de l'effectuer, il devra trouver un remplaçant par ses propres moyens et informer le responsable du service d'affectation.

D. Le congé :

Les externes ont droit à un mois de congé par an (le mois d'août). Avant les examens, la faculté établie le congé pour la préparation.

E. Les rémunérations :

Une indemnité de stage est octroyée par le Ministère de la santé au cours de l'externat et du stage interné.

F. Les sanctions :

Toute faute grave, falsification du carnet de stage ou atteinte au prestige et au bon renom de la faculté exposent à une sanction pouvant aller jusqu'à l'exclusion.

A cet égard, l'étudiant lors de l'accomplissement de son stage est soumis au respect du règlement intérieur de l'hôpital ; il se trouve placé à ce titre sous l'autorité :

- D'une part de la faculté en la personne du chef de service et des enseignants.

- D'autre part de l'administration du centre hospitalier où il effectue le stage.

IV- Déroulement des stages hospitaliers

Les objectifs de stage permettent au stagiaire d'avoir une idée précise des connaissances à intégrer au cours de sa formation. Ces objectifs représentent également un contrat entre deux parties : le service d'accueil et l'étudiant hospitalier qui s'engagent l'un à dispenser, l'autre à acquérir cette base d'enseignement.
En plus de la participation à la vie active du service, l'étudiant doit acquérir les objectifs nécessaires à la pratique médicale courante.

- Les séances d'apprentissage des objectifs :

L'apprentissage de ces objectifs se fait lors des séances d'apprentissage, organisées par chaque service, en fonction du nombre des objectifs. Le programme des séances, de même que le plan de formation en stage, est affiché au début des stages pour permettre aux externes de préparer les prérequis théoriques nécessaires à cet apprentissage.

- L'apprentissage des gestes :

L'apprentissage des techniques d'examen et des gestes fait appel à :

  - La démonstration du geste suivie de sa pratique, ou sa simulation
  - L'illustration par des diapositives, enregistrements ou films.
  - Des exercices de répétition.

- L'apprentissage des démarches diagnostiques :

Cet apprentissage se fait sous forme d'étude de cas soit libre, soit par petits groupes, à raison d'une démarche en moyenne par séance. La préparation du prérequis est indispensable pour ces séances.

- L'apprentissage par raisonnement clinique : Les séances d'ARC se déroulent en petits groupes d'externes donc d'étudiants de niveau de formation homogène et sous la supervision d'un professeur clinicien du domaine disciplinaire

- L'apprentissage des attitudes :

Cet apprentissage se fait lors des consultations, ou sous forme de jeux de rôles suivis de discussions portant sur l'attitude du médecin, le contenu du message, la manière de le transmettre et de le recevoir.

V- Nature des stages hospitaliers

Durant les deux premières années d'étude médicale, l'étudiant doit valider un module sous forme de stage d'immersion dans les structures de soin d'une durée de 3 semaines, après réussite des examens de fin d'année et un stage de médecine sociale en 2ème année d'une durée de 3 semaines également.

La formation pratique comporte quatre variétés de stages :

- Le stage de sémiologie – soins infirmiers,
- Le stage d'externat :
    - Stages fondamentaux de passage obligatoires : stage fondamental de médecine, stage fondamental de chirurgie, stage fondamental de pédiatrie et stage fondamental de gynéco-obstétrique
    - Stages de spécialités.
- Le stage d'externat plein temps
- Le stage interné

A. Le stage de sémiologie – soins infirmiers :

Ce stage se déroule les matinées, durant le 5ème semestre des études médicales. Il commence début septembre et se termine en octobre. Les étudiants sont répartis par groupes, encadrés par un responsable de stage. Ce stage se déroule dans les services hospitaliers. Les objectifs du stage sont mis à la disposition des étudiants au début du stage. Des séances d'apprentissage des objectifs sont organisées par tous les services. La présence durant ce stage est obligatoire.

B. Le stage d'externat :

Ce stage se déroule du 5ème au 10ème semestre des études médicales. Il comprend 4 stages fondamentaux : Médecine, Chirurgie, Pédiatrie et Gynécologie-Obstétrique (environ deux mois chacun) et des stages complémentaires (de durée variable de 6 à 8 semaines).

Ces stages se déroulent dans les différents services du C.H.U de Marrakech et l'hôpital militaire de Marrakech.

Le cursus proposé est le suivant :

- **3ème année :**
    - Stage de soins infirmiers et de sémiologie : 6 semaines.
    - Deux stages fondamentaux de 2 mois : Médecine et Chirurgie.
    - Deux stages complémentaires de 6 à 8 semaines.

Services de Médecine	Services de Chirurgie
Gastro- entérologie Médecine interne Cardiologie Pneumologie Maladies infectieuses Neurologie	Chirurgie viscérale Neurochirurgie Traumatologie

- **4ème année**
    - Stage fondamental de Pédiatrie de 2 mois.
    - Quatre stages complémentaires de 2 mois

Services de Pédiatrie : **Pédiatrie A et Pédiatrie B**.

Les autres services sont **réalisés dans les services représentés sur le tableau ci-dessous :**

Service de Médecine	Service de Chirurgie
Néonatologie Urgences pédiatriques Oncologie pédiatrique Dermatologie Hématologie Oncologie Rhumatologie Néphrologie Radiologie	Chirurgie Pédiatrique Chirurgie Cardio vasculaire Urologie Chirurgie vasculaire Chirurgie thoracique

- **5ème année**
    - Stage fondamental de Gynécologie-obstétrique de 2 mois
    - Quatre stages complémentaires de 2 mois

Les autres services sont dans le tableau ci-dessous :

Services de Médecine	Service de Chirurgie
Psychiatrie	ORL
Endocrinologie	Ophtalmologie
Néphrologie	Chirurgie Maxillo-faciale
Réanimation médico-chirurgicale	Chirurgie vasculaire
Laboratoire, génétique	Chirurgie plastique

Une fois à l'hôpital, le stagiaire doit savoir qu'il est devenu un acteur de soins, mais il n'est pas autonome :

- Le stagiaire doit acquérir les notions fondamentales en matière d'élimination des déchets hospitaliers,
- Le stagiaire doit connaître les mesures de prévention des accidents exposants au sang.
- Le stagiaire doit être vacciné contre l'hépatite B.

A tour de rôle, les stagiaires doivent participer aux gestes médicales et chirurgicales.

Le stagiaire doit être disponible pour suivre son tuteur à la consultation.

C. Le stage d'externat plein temps :

Le stage d'externat plein temps dure un an et se déroule durant le 11ème et le 12ème semestre, dans les services du CHU Mohammed VI, l'hôpital militaire de Marrakech et les centres de santé agrées matin et après-midi. Les étudiants sont affectés dans les services suivants :

- Services de Gynécologie obstétrique : A et B
- Services de Médecine : Cardiologie, Pneumologie, Gastro-entérologie, Médecine interne, Neurologie, Nephrologie ,Endocrinologie, Oncologie, Rhumatologie, Infectiologie, Hématologie, Dermatologie.

- Services de Chirurgie:Chirurgie viscérale, Traumatologie, Neurochirurgie, Chirurgie cardio-vasculaire, Chirurgie maxillo-faciale, Chirurgie plastique, ORL, Chirurgie Thoracique.

- Services de L'enfant : Néonatologie, Pédiatrie A et B, Chirurgie pédiatrique A et B, Oncologie pédiatrique, Urgences pédiatriques.

- Centres de santé de la ville de Marrakech.

Le stage d'externat plein temps permet à l'étudiant de confronter ses connaissances théoriques aux réalités quotidiennes dans les différents services. L'étudiant aura la responsabilité des malades sous la direction d'un enseignant. Il lui permet également de rattraper les objectifs non validés au cours des stages d'externat.

D. Le stage interné :

Le stage interné se déroule les 13ème et 14ème semestre des études médicales dans les formations sanitaires agrées en dehors du CHU. Il dure une année. Pour accéder à ce stage l'étudiant doit valider tous les stages antérieurs.

La répartition et l'affectation ont lieu à la faculté en présence d'un représentant du ministère de la santé. Le choix des postes attribués par le ministère se fait par ordre de mérite. L'affectation à ce stage est faite selon les besoins du ministère de la santé dans les hôpitaux du royaume.

Le stage interné comprend un stage de médecine et de centre de santé, un stage de chirurgie, un stage de gynécologie obstétrique et un stage de pédiatrie.

La validation de ces stages est obligatoire pour se présenter aux examens cliniques .

VI- L'évaluation des stages hospitaliers

A-Rappel des dispositions réglementaires :

- Un stage non validé doit être revalidé dans sa totalité.
- La revalidation d'un stage ne peut se faire parallèlement au déroulement d'un autre stage.
- Les étudiants devant revalider leur stage doivent s'inscrire auprès du service de scolarité-stages. Ils seront répartis en fonction de la capacité d'accueil du service où le stage n'a pu être validé.
- Ne peuvent être admis au stage interné que les externes ayant validé tous les stages, de même que la liste des gestes pratiques communs des objectifs des stages.

B-Critère et modalités de validation :

a-Règles générales :

- La notation est sur 100
- L'évaluation périodique (Attitudes, assiduité et activités de stage) est notée sur 50 points.
- L'évaluation finale par ECOS (examen clinique objectif et structuré) est notée sur 40 points.

b-L'évaluation du stage repose sur quatre volets :

1. L'assiduité :

- L'assiduité est considérée comme élément d'admissibilité pour la validation. L'évaluation de l'assiduité repose sur le nombre d'absences.
- Est considérée comme absence l'arrivée de l'étudiant au-delà de 15 min après l'horaire de début de l'activité du service. Cet horaire est fixé par le chef du service.
- Est considéré comme non assidu, donc non admissible pour la validation de son stage tout étudiant ayant cumulé plus de 2 absences non justifiées ou des absences justifiées représentant plus de 10% jours ouvrables de la durée de stage.

Une absence est dite justifiée dans 3 situations :

- Absence pour maladie avec un certificat médical déposé dans les premières 48 h du premier jour de l'absence sans dépassé une durée d'absence supérieur ou égale à 10% jours ouvrables de la durée de stage.
- Décès d'un parent de premier degré.
- Mariage après avoir averti le responsable de stage

La durée d'absence pour le décès et le mariage est fixée à 3 jours.

Une seule absence non justifiée au cours de la garde invalide automatiquement le stage.

Aucune note n'est attribuée à l'assiduité étant donné que c'est un élément d'admissibilité.

2. Comportement :

Une note sur 20 est attribuée au comportement. Trois composantes rentrent dans l'évaluation du comportement de l'étudiant dans le stage :

- La tenue vestimentaire : sur une note de 5.
- L'intégration au sein de l'équipe : sur une note de 10.
- Le comportement vis-à-vis des patients : sur une note de 5.

Le comportement de l'étudiant est évalué par le tuteur puis validé par le référent de stage ou le chef de service.

Tableau I : Proposition d'une grille d'évaluation du comportement des étudiants au stage

		Non adéquat	Acceptable	Excellent
Présentation	Tenue vestimentaire	0	1	2
	Hygiène corporelle	0	1	2
Intégration au sein de l'équipe	Relation avec le personnel médical	0	1	2
	Relation avec le personnel paramédical	0	1	2
	Respect des règles et habitudes du service	0	1	2
	Respect des locaux et matériel du service	0	1	2
Relation avec les patients	Sens de responsabilité	0	1	2
	Attitude respectueuse et empathique envers les patients	0	1	2
	Respect des règles dans l'annonce des diagnostics	0	1	2
	Habileté à informer les patients concernant leur état et les actes qu'ils vont subir	0	1	2

3. Les objectifs du stage :

Les objectifs du stage sont évalués par une note sur 40. La validation des objectifs du stage fait partie de l'admissibilité. L'étudiant doit valider au moins 80% des objectifs du stage. Le cas échéant, il verra son stage invalidé.

La validation des objectifs du stage se fait par un membre de l'équipe médical, puis validée par le référent de stage ou le chef de service.

4. Notation des activités dans le stage : 40 points.

L'évaluation sanctionnelle au cours du stage se fait en tenant compte des objectifs du carnet de stage. L'attribution des notes se répartit selon le tableau suivant :

Activités de stage	Objectifs ..... : Examen clinique de patient et rédaction d'observation avec interprétation des examens complémentaires : ..... observations par stage de ..... semaines	10
	Objectifs ..... : - Soins et gestes (à évaluer sur le carnet de stage) : 0 point : Non acquis. 1 point : En cours d'acquisition. 2 points : Acquis. - Le total des points sera converti sur dix points (règle de trois tenant compte du total des points maximum pour chaque spécialité : total des points obtenus x 10).	10
	Objectifs ..... : - Élaboration par chaque étudiant d'un ou deux résumés structurés d'observation à partir d'un dossier complet de patient les derniers jours de stage. - Le dossier est choisi par l'encadreur selon la liste des pathologies courantes et urgentes présente dans le carnet de stage.	10
	Validation des gardes : - Compte-rendu de garde (rapport de chaque garde transmis au responsable de stage). - Nombre de gardes à préciser par spécialité.	10

c-L'évaluation de la fin du stage :

Une note sur 40 est attribuée à l'évaluation de la fin du stage.

L'évaluation de fin de stage est actuellement en cours d'être revue avec

comme objectif l'utilisation du système d'ECOS.

La mise en place du Système d'ECOS est attribuée à une sous-commission dédiée

C. L'importance du stage hospitalier :

Les stages sont pris en considération pour le passage d'une année à l'autre : Vu l'importance des stages hospitaliers dans la formation médicale de l'étudiant, le décret de réforme des études médicales de 1983 a prévu cette clause pour inciter les étudiants à ne pas favoriser les connaissances théoriques par rapport à la formation pratique.

VII- Les objectifs des stages hospitaliers

A- Les objectifs des stages hospitaliers de la fin de la 1ère et la 2ème année

STAGE D'IMMERSION DANS LES STRUCTURES DE SOIN 1ére année

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
- Connaitre l'organisation de soin d'une structure de santé - Connaitre la responsabilité du médecin envers le patient		
Connaitre les circuits et les modalités de prise en charge d'un patient		
-Se mettre en contact avec le patient : depuis son admission jusqu'à sa sortie de la structure hospitalière		
-Expérimenter la relation patient-médecin -Etre sensibilisé au vécu du patient et du médecin -S'initier au travail interdisciplinaire		
- Aider l'étudiant à réfléchir sur le professionnalisme médical et à soutenir sa motivation pour les études médicales		
-Assister aux différentes activités du service.		

Stage de médecine sociale 2éme année

Dans le cadre de réforme médical, le stage de médecine sociale destiné pour les étudiants de 2ème année de médecine, est en cours de validation par la commission pédagogique. Ces objectifs seront élaborés et appliqués durant l'année universitaire 2017-2018.

B- Les objectifs de stage de sémiologie soins infirmiers

Stage de sémiologie et des soins infirmiers

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Sémiologie		
Pratiquer un examen cardiaque chez un adulte normal		
Pratiquer un examen vasculaire chez un adulte normal		
Pratiquer un examen pleuro-pulmonaire chez un adulte normal		
Pratiquer un examen abdomino-pelvien chez un adulte normal		
Effectuer un examen programmé d'une articulation périphérique.		
Effectuer un examen programmé du rachis chez un adulte.		
Pratiquer un examen neurologique chez un patient normal		
Pratiquer l'examen des aires ganglionnaires chez un adulte normale		
Pratiquer un examen cutanéomuqueux		
Mener un interrogatoire orienté en fonction du motif de consultation chez un adulte		
Rédiger une observation clinique		
Soins infirmiers		
Effectuer un abord veineux périphérique pour prélèvement sanguin et perfusion intraveineuse.		
Prendre les constantes chez un patient adulte (pouls, fréquence respiratoire, pression artérielle, température)		
Pratiquer/ simuler une injection intramusculaire et/ou sous cutanée et/ou intradermique		
Faire un pansement chez un patient adulte		
Réaliser un prélèvement des urines pour ECBU		
Faire et interpréter des examens aux bandelettes réactives		
Tenir une feuille de température ou une fiche de surveillance		
Placer ou simuler la mise en place d'une sonde gastrique		
Placer ou simuler la mise en place en place d'une sonde urinaire		
Faire du nursing à un patient adulte hospitalisé		
Surveiller une transfusion sanguine		

C- Les objectifs de stage fondamental en Médecine et Chirurgie

Stage fondamentale de Médecine

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Démarches diagnostiques : ARC		
Démarche diagnostique devant une dyspnée		
Démarche diagnostique devant une douleur thoracique		
Démarche diagnostique devant des hémoptysies		
Démarche diagnostique devant un syndrome oedémato-ascitique		
Démarche diagnostique devant des arthrites/arthralgies		
Démarche diagnostique devant une hémorragie digestive		
Démarche diagnostique devant une hépatomégalie		
Démarche diagnostique devant une diarrhée		
Démarche diagnostique devant un déficit moteur		
Démarche diagnostique devant des céphalées		
Démarche diagnostique devant un syndrome méningé		
Interpréter une radiographie thoracique de face d'une adulte normal		
Interpréter une numération formule sanguine d'un sujet normal		
Interpréter les résultats cytobactériologiques et chimiques d'un liquide céphalo-rachidien		
Interpréter l'hémogramme d'un patient anémique		
Interpréter l'hémogramme d'un patient présentant un syndrome infectieux		
Interpréter la fonction rénale d'un patient présentant une insuffisance rénale		
Interpréter un examen cytobactériologique des urines		
Interpréter le bilan hépatique d'un patient présentant une cytolyse		
Interpréter le bilan hépatique d'un patient présentant une cholestase		
Etablir la démarche devant un accident d'exposition aux sangs		

STAGE FONDAMENTAL DE CHIRURGIE

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Rechercher une hépatomégalie, une splénomégalie		
Identifier cliniquement une grosse vésicule biliaire		
Reconnaitre un clapotage à jeun.		
Reconnaitre un empattement abdominal		
Reconnaitre une contracture abdominale		
Identifier une masse abdominale et préciser ces caractères		
Identifier un météorisme abdominal		
Palper un globe vésical		
Identifier et préciser les caractères d'une hernie inguinale, crurale, de la ligne blanche		
Reconnaître une éventration		
Identifier une collection liquidienne des parties molles		
Identifier un panaris		
Identifier une gangrène		
Identifier un comblement et /ou une sensibilité du cul de sac de Douglas.		
Rechercher une complication vasculo-nerveux d'un membre traumatisé		
Evaluer le score de Glasgow chez un patient ayant des troubles de conscience		
Reconnaitre les signes cliniques d'une hypertension intracrânienne chez un patient céphalalgique		
Apprécier au toucher rectal le volume et les caractéristiques de la prostate		
Apprécier les pouls périphériques		
Reconnaître et situer les varices des membres inférieurs		
Examiner le corps thyroïde		
Faire une démarche diagnostique devant une masse abdominale,		
Faire une démarche diagnostique devant une hémorragie digestive.		
Réaliser l'incision et le drainage d'un abcès chaud superficiel des parties molles.		
Pratiquer une anesthésie locale		
Faire des points de sutures cutanés		
Faire un lavage chirurgical des mains		
Porter correctement une casaque et des gants stériles		

D- Les objectifs spécifiques dans les services de Médecine

SERVICE DE RHUMATOLOGIE

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Mener l'anamnèse chez un patient atteint d'une affection rhumatologique		
Effectuer un examen programmé d'une articulation périphérique		
Effectuer un examen programmé du rachis		
Reconnaitre une synovite au cours d'un rhumatisme inflammatoire chronique		
Reconnaitre les principales déformations articulaires		
Reconnaitre une raideur articulaire au cours d'un rhumatisme inflammatoire chronique		
Reconnaitre une raideur rachidienne chez un lombalgique		
Identifier une scoliose chez un adulte		
Rechercher un choc rotulien au niveau du genou		
Reconnaitre les déformations articulaires de la polyarthrite rhumatoïde a la phase d'état		
Reconnaitre les signes radiologiques élémentaires de l'arthrose		
Reconnaitre les signes radiologiques élémentaires de l'arthrite		
Interpréter un examen d'ostéodensitométrie chez une patiente ostéoporotique		
Assister à une ponction articulaire du genou		
Interpréter le bilan d'auto-immunité au cours d'une polyarthrite		
Interpréter le bilan phosphocalcique		
Interpréter un examen cytobactériologique du liquide articulaire au cours d'une mono-arthrite aigue		
ARC : Prendre en charge une mono-arthrite aigue		
ARC : Prendre en charge une polyarthrite aigue		
ARC : Prendre en charge une lombosciatique		
ARC : Prendre en charge une fracture vertébrale		
ARC : Démarche diagnostique devant une douleur de l'épaule		
ARC : Démarche diagnostique devant une douleur de la hanche		

SERVICE DE CARDIOLOGIE : 3ème année

OBJECTIFS DU STAGE		DATE	VALIDATION
Relever sur la base des données anamnestiques les facteurs du risque cardio-vasculaire			
Relever sur la base des données anamnestiques et physiques les signes d'hypertension artérielle systémique.			
Relever à partir de l'examen physique les signes périphériques de l'insuffisance cardiaque droite chez un patient se présentant pour des œdèmes des membres inferieurs			
Identifier les signes physiques de l'insuffisance cardiaque gauche chez un patient se présentant pour une dyspnée.			
Surveiller cliniquement un patient hospitalisé pour une insuffisance cardiaque congestive			
Surveiller cliniquement et électriquement un patient hospitalisé pour un infarctus du myocarde			
Les souffles cardiaques	Décrire les caractéristiques sthétacoustiques d'un souffle cardiaque retrouvé chez un patient porteur d'une insuffisance mitrale.		
	Décrire les caractéristiques sthétacoustiques d'un roulement cardiaque retrouvé chez un patient porteur d'un rétrécissement mitral.		
	Décrire les caractéristiques sthétacoustiques d'un soufflé cardiaque retrouvé chez un patient porteur d'une insuffisance aortique.		
	Décrire les caractéristiques sthétacoustiques d'un soufflé cardiaque retrouvé chez un patient porteur d'un rétrécissement aortique.		

ECG normal et pathologique	Evoquer sur un tracé électrique un trouble de rythme/conduction.		
	Vérifier un tracé électrique d'un patient adulte, le rythme cardiaque		
	Calculer la fréquence cardiaque sur un ECG normal.		
	Calculer l'axe du cœur sur un ECG normal.		
	Identifier sur un tracé électrique d'un patient valvulaire, les signes des hypertrophies cavitaires.		
	Identifier les anomalies électriques retrouvées chez un patient présentant un infarctus du myocarde à la phase aigüe.		
	Déceler sur un tracé électrique, les troubles de la repolarisation chez un patient coronarien stable.		
	Décrire l'aspect des arcs de la silhouette cardiaque sur une radiographie thoracique de face d'un sujet normal.		
	Décrire sur une radiographie thoracique d'un patient valvulaire, les anomalies des arcs de la silhouette cardiaque.		
	Reconnaitre sur une radiographie thoracique de face, le stade de l'insuffisance cardiaque		
ARC	Démarche diagnostique devant une dyspnée		
	Démarche diagnostique devant des douleurs thoraciques		
	Démarche diagnostique devant une fièvre chez un patient cardiaque (fièvre + Souffle)		
	Démarche diagnostique devant des œdèmes des membres inferieurs		
	Démarche diagnostique devant un gros membre inferieur		
Surveiller cliniquement un patient hospitalisé pour une insuffisance cardiaque décompensée			
Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour insuffisance cardiaque			
Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour un infarctus de myocarde			

SERVICE DE CARDIOLOGIE : 6ème année

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour une endocardite infectieuse.		
Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour insuffisance cardiaque		
Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour un infarctus de myocarde		
Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour insuffisance cardiaque décompensée.		
Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour un infarctus de myocarde		
Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour un rhumatisme articulaire aigu		
Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour une maladie veineuse thrombo-embolique.		
Surveiller cliniquement un patient hospitalisé pour une insuffisance cardiaque décompensée		
Surveiller cliniquement et biologiquement un patient hospitalisé pour une poussée de rhumatisme articulaire aigu		
Expliquer les moyens de prévention de l'endocardite infectieuse à un patient suivi pour une cardiopathie rhumatismale chronique.		
Expliquer les moyens de prévention de la rechute rhumatismale chez un patient ayant des antécédents de rhumatisme articulaire aigu.		
Surveiller un patient sous traitement anticoagulant		
Expliquer les mesures hygiéno-diététiques à un patient à haut risque cardio-vasculaire		
Expliquer le régime à un patient hypertendu		
Diagnostiquer par les données anamnestiques et physiques une urgence hypertensive.		
Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour insuffisance cardiaque		

Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour un infarctus de myocarde			
Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour insuffisance cardiaque décompensée.			
Rédiger l'observation d'un patient hypertendu			
Surveiller cliniquement un patient hospitalisé pour une insuffisance cardiaque décompensée			
ARC	Démarche diagnostique devant une cyanose		
	Démarche diagnostique devant une polyarthrite survenant à la suite d'une infection post-streptococcique.		

SERVICE DE DERMATOLOGIE

OBJECTIFS DU STAGE		DATE	VALIDATION
Identifier les lésions élémentaires en dermatologie			
Interpréter une sérologie syphilitique			
ARC : Mener une enquête étiologique devant	Un prurit chronique		
	Une ulcération génitale		
	Un érythème noueux		
	Une jambe inflammatoire		
Identifier cliniquement des lésions pré-cancéreuses cutanéo-muqueuses			
Évoquer une tumeur maligne cutanée en se basant sur l'anamnèse et l'examen clinique			
Rédiger une ordonnance pour	Un adolescent atteint de l'acné		
	Un enfant atteint d'une teigne		
	Un patient atteint d'une gale		
	Un patient atteint d'un psoriasis en plaque		
	Un patient atteint d'une infection bactérienne cutanée		
	Un patient atteint d'une infection virale cutanée		
	Un patient atteint d'une infection mycosique cutanée superficielle		
	Un patient atteint d'un eczéma de contact		
	Un patient atteint d'une urticaire aigue ou chronique		
Rechercher cliniquement des signes d'atypie d'un nævus			
Planifier le traitement d'une IST			
Réaliser un pansement chez un patient atteint d'ulcère de jambe chronique			
Réaliser un prélèvement bactériologique d'une lésion dermatologique			
Réaliser un prélèvement parasitologique des squames et des cheveux			

SERVICE D'ENDOCRINOLOGIE ET MALADIES MÉTABOLIQUES

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Diabétologie		
Mesurer une glycémie capillaire		
Confirmer sur un bilan biologique le diagnostic d'un diabète sucré chez un patient avec hyperglycémie de découverte récente		
Relever d'après l'interrogatoire chez un patient diabétique les critères cliniques orientant vers diabète de type 2		
Relever d'après l'interrogatoire chez un patient diabétique les critères cliniques orientant vers diabète de type 1		
Préparer un chariot pour la correction d'une hypoglycémie chez un patient diabétique insulinotraité		
Relever à l'examen clinique chez un patient hospitalisé les signes confirmant une acidocétose diabétique		
Élaborer une stratégie de correction d'une acidocétose diabétique chez un jeune patient diabétique de type 1		
Retrouver à l'anamnèse et à l'examen clinique les signes orientant vers ces complications dégénératives du diabète : • Néphropathie • Neuropathie périphérique et autonome • Rétinopathie		
Dépister la neuropathie diabétique à l'aide d'un monofilament chez un patient diabétique avec lésion chronique du pied		
Mener une séance d'éducation thérapeutique sur les techniques d'injection de l'insuline chez un patient diabétique insulinotraité		
Rédiger un bon de demande de bilan de suivi trimestriel chez un diabétique		
Endocrinologie		
Identifier un goitre modéré à la palpation		
Relever à l'examen clinique les signes d'une hyperthyroïdie chez un patient adulte		
Relever à l'examen clinique les signes d'une hypothyroïdie chez un patient adulte		

Chercher les signes cliniques d'un hypercorticisme chez un patient adulte		
Rattacher des éléments anamnestiques et clinique à une insuffisance surrénalienne aigue		
Interpréter un hypophysiogramme chez un patient avec insuffisance antéhypophysaire		
Hypoglycémie chez le non diabétique (ARC)		
Obésité (ARC)		
Nodule thyroïdien (ARC)		
Retard de croissance staturale (ARC)		
Hypogonadisme (ARC)		

SERVICE DE GASTRO-ENTEROLOGIE

OBJECTIFS DU STAGE		DATE	VALIDATION
Caractériser une hépatomégalie chez un cirrhotique			
Reconnaitre une splénomégalie dans le cas d'un syndrome d'hypertension portale			
Reconnaitre cliniquement un ictère cholestatique d'origine médicale			
Reconnaitre une ascite face à une distension abdominale chez un cirrhotique			
Interpréter les résultats chimiques et cytologiques d'une ponction d'ascite			
Reconnaitre le mode d'extériorisation d'une hémorragie digestive chez un cirrhotique			
Reconnaitre le mode d'extériorisation d'une hémorragie digestive chez un ulcéreux			
Reconnaître les signes de gravité d'une hémorragie digestive			
Caractériser une épigastralgie lors d'un ulcère gastro-duodénal			
Caractériser une épigastralgie lors d'une pancréatite			
Reconnaître les lésions proctologiques courantes : (fistule anale, fissure et Hémorroïdes)			
Caractériser une diarrhée chronique			
ARC	Hémorragie digestive		
	Vomissements		
	Ascite		
	Ictère		
	Insuffisance hépatocellulaire		
	Diarrhée		

SERVICE D'HÉMATOLOGIE CLINIQUE

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Interpréter un hémogramme		
Interpréter un bilan d'hémostase		
Argumenter les indications d'un myélogramme		
Argumenter les indications d'une biopsie ostéomédullaire		
Élaborer la démarche diagnostique devant une pancytopénie		
Élaborer la démarche diagnostique devant une thrombopénie		
Élaborer la démarche diagnostique devant une anémie		
Élaborer la démarche diagnostique devant une polyglobulie		
Élaborer la démarche diagnostique devant une thrombocytose		
Élaborer la démarche diagnostique devant une polynucléose neutrophile		
Élaborer la démarche diagnostique devant une hyperlymphocytose		
Élaborer la démarche diagnostique devant une lymphopénie		
Élaborer la démarche diagnostique devant une neutropénie		
Élaborer la démarche diagnostique devant une hyperéosinophilie		
Élaborer la démarche diagnostique devant une adénopathie		
Réaliser un acte transfusionnel		
Élaborer la démarche diagnostique et thérapeutique devant neutropénie fébrile		
Élaborer la démarche diagnostique et thérapeutique devant syndrome de lyse tumorale		
Élaborer la démarche diagnostique et thérapeutique devant coagulation intravasculaire disséminée		
Élaborer la conduite à tenir devant un hémophile qui saigne		

SERVICE DE MÉDECINE INTERNE

OBJECTIFS DU STAGE		DATE	VALIDATION
ARC	Anémie		
	Purpura		
	Adénopathie-splénomégalie		
	Fièvre prolongée		
	Amaigrissement		
	Syndrome oedémateux		
	Maladie thrombo-embolique veineuse		
Maladie systémique	Reconnaître les signes cliniques devant faire suspecter une maladie auto-immune (lupus systémique, myosites inflammatoires…)		
	Reconnaitre les signes cliniques devant suspecter une vascularite (Behçet, artérite à cellules géantes…)		
	Reconnaitre les signes cliniques devant suspecter une granulomatose (sarcoïdose, tuberculose...)		
Corticothérapie prolongée	Reconnaître les complications d'une corticothérapie prolongée.		
	Etablir les mesures de prévention et de surveillance		
	Etablir les mesures d'accompagnement d'un traitement par corticoïdes.		
Gériatrie	Reconnaître les signes de gravité imposant une hospitalisation chez un patient âgé.		
	Rationaliser les traitements de la personne âgée en fonction des particularités pharmacologiques gériatriques.		
Interprétation des examens	Analyser les examens para cliniques biologiques courants : Interpréter un hémogramme, un bilan de coagulation… une électrophorèse des protéines, des troubles ioniques : dyskaliémie, natrémie, métabolisme phosphocalcique, syndrome inflammatoire biologique, syndrome de malabsorption…)		
	S'initier à l'interprétation des examens radiologiques simples : radiographie du thorax, radiographie du squelette.		
	Ponction d'ascite		
	Ponction pleurale.		

SERVICE DE MALADIES INFECTIEUSES

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Reconnaître un syndrome méningé chez un patient qui consulte pour des céphalées		
Réaliser (en simulation) une ponction lombaire devant la suspicion d'une méningite		
Interpréter une ponction lombaire		
Prendre en charge un AES		
Réaliser l'examen des urines par des bandelettes urinaires devant une suspicion d'infection urinaire		
Expliquer à un malade le prélèvement d'urine pour la réalisation d'un ECBU		
Interpréter les résultats d'un ECBU		
Reconnaître les situations cliniques et paracliniques devant lesquelles il faut réaliser une sérologie VIH		
Réaliser le test rapide VIH devant la suspicion d'infection à VIH et interpréter son résultat		
Pratiquer l'hygiène des mains avant un soin		
Reconnaître une ADP devant une masse cervicale		
Reconnaître un sepsis devant un patient fébrile		
Prescrire les examens de 1ère intention à réaliser devant une fièvre prolongée		
Reconnaître une rickettsiose devant une éruption fébrile		
Réunir les arguments épidémiologiques et cliniques en faveur de la leptospirose devant un ictère fébrile		
Prendre en charge une morsure d'animal		
Reconnaître le tétanos devant un trismus		
Effectuer les soins nécessaires devant une plaie pour prévenir le tétanos		

SERVICE DE NÉPHROLOGIE

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Élaborer une courbe de suivi de la pression artérielle et du poids chez un patient présentant un syndrome œdémateux		
Interpréter la courbe de poids d'un patient présentant un syndrome œdémateux		
Reconnaître les signes en faveur de l'origine rénale d'un syndrome œdémateux chez un sujet âgé		
Reconnaître la démarche diagnostique devant une anomalie de la bandelette urinaire chez une femme jeune		
Reconnaître la démarche diagnostique devant une albuminurie positive chez un patient diabétique		
Reconnaître les symptômes d'un syndrome glomérulaire chez un adulte		
Poser l'indication d'une biopsie rénale devant un syndrome néphrotique chez un adulte		
Poser l'indication d'une biopsie rénale devant un syndrome néphrétique aigu chez un grand enfant		
Rechercher le caractère secondaire d'une néphropathie chez une patiente avec un sédiment urinaire actif		
Reconnaître les signes en faveur du caractère chronique de l'insuffisance rénale		
Évaluer la fonction rénale chez un sujet âgé		
Calculer le débit de filtration glomérulaire chez un adulte		
Élaborer une courbe de suivi de protéinurie et de la fonction rénale chez un patient présentant une insuffisance rénale		
Interpréter les images d'une échographie rénale chez un patient présentant une insuffisance rénale.		
Interpréter l'ionogramme sanguin d'un patient insuffisant rénal		
Interpréter l'ionogramme urinaire chez un patient présentant une hypokaliémie		
Prescrire un traitement symptomatique chez un patient présentant un syndrome néphrotique		
Prescrire un traitement antihypertenseur chez un patient diabétique avec néphropathie		
Raisonnement devant un syndrome œdémateux (ARC) Raisonnement devant une dyspnée (ARC)		
Poser l'indication d'une hémodialyse en urgence chez un patient insuffisant rénal		
Poser l'indication d'une initiation à l'hémodialyse chez un patient insuffisant rénal chronique		
Reconnaître une fistule artério-veineuse chez un hémodialysé chronique		
Examiner une fistule artério-veineuse chez un hémodialysé chronique		

SERVICE DE NEUROLOGIE

OBJECTIFS DU STAGE		DATE	VALIDATION
Réaliser un examen neurologique chez l'adulte			
Réaliser un test simple d'évaluation des fonctions cognitives chez un adulte			
Reconnaitre un syndrome cérébelleux chez un patient présentant des troubles de la marche			
Reconnaitre un syndrome parkinsonien			
Poser le diagnostic d'un syndrome pyramidal chez un patient présentant un déficit moteur			
Établir le diagnostic d'un syndrome myogène chez un patient présentant un déficit moteur			
Poser le diagnostic d'un syndrome neurogène périphérique chez un patient ayant un déficit moteur ou sensitif			
Poser le diagnostic d'un syndrome vestibulaire chez un patient présentant des vertiges			
Établir le diagnostic d'épilepsie chez un patient ayant des phénomènes critiques			
Poser l'indication de l'électroencéphalographie chez un patient présentant une perte de connaissance			
Interpréter les résultats du Liquide cérébrospinal chez un patient ayant un syndrome méningé			
Relever les anomalies radiologiques sur un scanner cérébral chez un patient présentant un AVC ischémique			
Relever les anomalies radiologiques sur une IRM encéphalique chez un patient présentant une sclérose en plaque			
ARC	Céphalées		
	Déficit moteur		
	Déficit sensitif		
	Vertiges		

SERVICE DE PNEUMOPHTISIOLOGIE

-Stage en 3éme année

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Réaliser un examen pleuro-pulmonaire chez un adulte		
Interpréter une radiographie thoracique de face.		
Décrire les différents syndromes radiologiques sur une radiographie thoracique de face (Pleural, pariétal, médiastinal, parenchymateux, emphysémateux)		
Interpréter les résultats d'une bacilloscopie d'un patient tuberculeux.		
Poser le diagnostic d'une bronchite aigue simple chez l'adulte.		
Poser le diagnostic d'une pneumopathie communautaire chez l'adulte.		
Évaluer la sévérité d'une pneumopathie communautaire chez l'adulte.		
Poser le diagnostic d'une dilatation de bronches chez un adulte		
Poser le diagnostic d'un carcinome bronchogénique chez un adulte		
Reconnaitre un asthme chez un patient asthmatique.		
Évaluer la gravité d'une crise d'asthme chez un patient asthmatique.		

-Stage en 6éme année

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Rédiger une ordonnance du traitement anti bacillaire d'une tuberculose pulmonaire de catégorie 1		
Déceler les effets indésirables d'un traitement anti-bacillaire chez un adulte.		
Programmer la surveillance d'un traitement anti-bacillaire chez l'adulte.		
Prescrire le traitement d'une crise d'asthme.		
Prescrire le traitement de fond de l'asthme.		
Expliquer l'usage des médicaments en inhalation et la chambre d'inhalation à un patient asthmatique.		
Rédiger une ordonnance pour un patient porteur d'une pneumopathie communautaire.		
Interpréter les données d'une gazométrie artérielle		
Déterminer le stade de sévérité chez un patient BPCO		
Prescrire le traitement d'une BPCO chez l'adulte		

Taches d'apprentissage

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Assister à une spirométrie		
Assister à une bronchoscopie souple		
Assister à une consultation de pneumologie		
Assister à une consultation d'allergologie		
Assister à la consultation d'aide au sevrage tabagique		
Assister à la réalisation d'une gazométrie artérielle		

Séances d'ARC

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Élaborer une démarche diagnostique devant une Dyspnée		
Élaborer une démarche diagnostique devant une Hémoptysie		
Élaborer une démarche diagnostique devant une Toux chronique		
Élaborer une démarche diagnostique devant une Douleur thoracique		
Élaborer une démarche diagnostique devant une opacité suspecte chez un patient tabagique		
Élaborer une démarche diagnostique devant une Dyspnée		

SERVICE DE PSYCHIATRIE

OBJECTIFS DU STAGE		DATE	VALIDATION
Reconnaître les signes d'un Etat Dépressif Caractérisé chez un adulte jeune sans antécédents psychiatriques.			
Reconnaître les particularités d'un Etat Dépressif Caractérisé chez le sujet âgé.			
Justifier l'orientation psychiatrique d'un patient déprimé.			
Diagnostiquer un trouble panique chez un adulte jeune consultant pour des manifestations somatiques.			
Dépister les conduites addictives chez un patient jeune consultant en médecine générale.			
Reconnaître un abus de cannabis chez un sujet jeune consultant pour un changement de comportement.			
Reconnaître une dépendance au cannabis chez un sujet jeune consultant pour un changement de comportement.			
Reconnaître une crise suicidaire chez un patient consultant pour un changement de son comportement.			
Evaluer le potentiel suicidaire chez un patient consultant pour une crise suicidaire.			
Reconnaître un syndrome confusionnel chez un sujet jeune se présentant pour trouble du comportement.			
Conduire un Traitement Antidépresseur chez un patient déprimé.			
Conduire un traitement anxiolytique Benzodiazépénique.			
Reconnaître les signes précoces d'un syndrome malin des neuroleptiques chez un patient fébrile sous traitement antipsychotique.			
Identifier les effets secondaires d'un traitement thymorégulateur chez un patient suivi en psychiatrie.			
Identifier les effets secondaires d'un traitement antipsychotique chez un patient suivi en psychiatrie.			
Pratiquer un entretien psychiatrique chez un patient schizophrène.			
Pratiquer un entretien psychiatrique chez un patient ayant un trouble de l'humeur : accès dépressif et accès maniaque.			
Pratiquer un entretien psychiatrique chez un patient présentant un trouble anxieux.			
Assister à une activité ergothérapique.			
Assister à une séance de groupe de parole.			
ARC	Conduite à tenir devant une agitation psychomotrice.		
	Conduite à tenir devant un état délirant aigu.		
	Conduite à tenir devant une insomnie.		
	Conduite à tenir devant une anorexie.		
	Conduite à tenir devant un Délirium Tremens.		

SERVICE DE MÉDECINE PHYSIQUE ET RÉADAPTATION FONCTIONNELLE

OBJECTIFS DU STAGE		DATE	VALIDATION
Reconnaitre les déficiences sensitivo- motrices chez un blessé médullaire			
Expliquer l'auto-sondage et hétéro-sondage chez un blessé médullaire			
Évaluer la gravité d'un blessé médullaire selon l'ASIA (American Spinal Injury Association).			
Annoncer le pronostic fonctionnel chez un blessé médullaire.			
Évaluer la douleur selon les échelles d'évaluation chez un patient ayant une lombalgie.			
Identifier les séquelles neuro orthopédiques chez un patient atteint d'un Accident vasculaire cérébral.			
Reconnaitre les complications de décubitus chez un sujet alité.			
Évaluer le retentissement social et professionnel chez un handicapé.			
Reconnaitre les séquelles neuro psychologiques chez un patient atteint d'un traumatisme crânien.			
Recommander les aides techniques et humaines chez un traumatisé crânien sévère			
Chercher les déficiences chez un enfant atteint d'une infirmité motrice cérébrale.			
Évaluer l'équilibre chez un patient atteint d'un syndrome cérébelleux			
Chercher les incapacités chez un patient ayant une fracture de membre inferieur.			
Évaluer la force musculaire chez un patient atteint d'une myopathie.			
Pratiquer les moyens thérapeutiques non médicamenteux de la douleur chez un patient atteint d'un rhumatisme inflammatoire chronique.			
Réaliser le bilan articulaire chez un malade polytraumatisé			
Réaliser le bilan de sensibilité chez un patient avec radiculalgie de membre			
Expliquer l'auto rééducation à un patient :	lombalgique		
	Arthrosique de membre inférieur		
Reconnaitre les troubles statiques du pied chez un patient neurologique			
Reconnaitre les troubles statiques du pied chez un patient diabétique			
Reconnaitre une scoliose chez un patient ayant une déviation rachidienne			
Reconnaitre les principes thérapeutiques de rééducation chez un patient ayant une :	Scoliose.		
	Capsulite rétractile		
	Tendinopathie de la coiffe des rotateurs		
	Spondylarthrite ankylosante		
	Fracture de membre inférieur		
Utiliser les moyens de gain de mobilité chez un patient porteur d'une prothèse.			
Connaitre les différents appareillages chez un diabétique compliqué			

SERVICE DE RADIOTHÉRAPIE-ONCOLOGIE

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Examiner un nodule du sein suspect de malignité		
Examiner un col de l'utérus tumoral		
Examiner une adénopathie latéro cervicale lors d'un cancer de la sphère ORL		
Poser le diagnostic d'une ascite lors d'un cancer		
Poser le diagnostic d'une pleurésie lors d'un cancer		
Observation médicale en oncologie		
Réaliser une observation médicale des cancers les plus fréquents - Cancer du sein - Cancer du col de l'utérus - Cancer de l'estomac - Cancer du rectum - Cancer du poumon - Cancer ORL		
Élaborer une stratégie thérapeutique d'un : - Cancer du sein localisé ou métastatique - Cancer localisé ou localement avancé du col de l'utérus - Cancer du rectum - Cancer du poumon - Cancer du larynx		
Reconnaitre les toxicités spécifiques et non spécifiques chez un patient sous antimitotiques		
Interpréter une numération formule sanguine d'un syndrome d'insuffisance médullaire post chimiothérapie.		
Élaborer une démarche diagnostique chez un patient présentant une neutropénie fébrile post chimiothérapie		
Prescrire un traitement anti émétique chez un patient sous chimiothérapie		
Reconnaitre les toxicités aigues et tardives chez un patient ayant eu une radiothérapie		
Traitements palliatifs et soins de support		
Évaluer une douleur chronique chez un cancéreux adulte à l'aide de l'échelle visuelle analogique		
Prescrire un traitement d'une douleur modérée		
Rédiger une ordonnance à base de morphine chez un cancéreux		
Simuler une consultation d'annonce d'un diagnostic de cancer chez un patient adulte		
Réalisation de gestes pratiques		
Réaliser une ponction d'ascite		
Réaliser un méchage hémostatique pour cancer du col de l'utérus		

SERVICE DE RADIOLOGIE

OBJECTIFS DU STAGE		DATE	VALIDATION
Relever par l'interrogatoire les contres indications chez un patient adressé pour une exploration utilisant les rayons X.			
Relever par l'interrogatoire les contres indications chez un patient adressé pour une IRM.			
Déceler par l'interrogatoire les contres indications avant toute injection de produit de contraste.			
Imagerie thoracique	Interpréter une radiographie pulmonaire normale de face et de profil chez l'adulte.		
	Reconnaitre les signes sémiologiques d'un syndrome alvéolaire sur la radiographie pulmonaire de face.		
	Reconnaître les signes sémiologiques d'un syndrome interstitiel sur une radiographie pulmonaire de face.		
	Relever les signes radiologiques de malignité d'une opacité tumorale du parenchyme pulmonaire chez un patient non traité.		
	Localiser une opacité médiastinale sur la radiographie standard de face.		
	Identifier un épanchement pleural aérique ou liquidien sur un cliché standard et au scanner.		
	Identifier un syndrome bronchique sur un cliché standard et sur un scanner.		
	Reconnaître les signes sémiologiques d'une tuberculose pulmonaire sur un cliché standard chez l'immunocompétent.		
	Reconnaître un emphysème sur une radiographie standard chez l'adulte.		
	Différencier sur une radiographie thoracique de face une opacité pleuro-pariétale d'une opacité pulmonaire.		
	ARC : Opacité excavée		
Imagerie Digestive	Interpréter un cliché d'ASP normal d'un adulte.		
	Reconnaître les niveaux hydro-aériques d'origine grêlique et colique sur un ASP réalisé chez un patient debout.		
	Reconnaître un pneumopéritoine sur un cliché standard réalisé en position debout.		
	Reconnaitre les différents organes visibles sur un scanner abdominal normal.		

Imagerie urologique	Analyser un AUSP chez l'adulte.		
	Reconnaître un calcul radio opaque sur AUSP chez un adulte.		
Neuro-radiologie	Reconnaitre les différentes structures identifiables sur un scanner cérébral normal.		
	Reconnaitre un AVCI et AVCH sur un scanner cérébral.		
	Déceler sur un scanner les différentes lésions post traumatiques de l'encéphale.		
	Interpréter une radiographie normale du rachis de l'adulte.		
	Déceler les signes de l'arthrose rachidienne sur la radiographie standard.		
Radiologie Ostéo-articulaire	Interpréter une radiographie articulaire chez un adulte.		
	Reconnaître les signes radiologiques du mal de pott sur un cliché standard.		
	Reconnaître les signes d'arthrose sur une radiographie standard.		
	ARC : ostéolyse osseuse		
Imagerie De la femme	Interpréter une hystérosalpingographie normale.		
	Analyser une mammographie normale chez la femme jeune et la femme âgée.		
	ARC : Nodule mammaire sur la mammographie.		
Imagerie De l'enfant	Interpréter un ASP chez le nouveau-né.		
	Interpréter une radiographie thoracique chez l'enfant.		
	Reconnaitre un reflux vésico-urétérale et sa stadification sur un UCG chez un enfant.		
	Relever les signes d'ostéo-chondrite primitive de hanche sur la radiographie de hanche de l'enfant.		
	Déceler les signes d'une LCH sur une radiographie du bassin chez un nourrisson de 4 mois.		

E-Les objectifs spécifiques dans les services de chirurgie

SERVICE DE CHIRURGIE CARDIOVASCULAIRE

- Stage en 4ème Année

OBJECTIFS DU STAGE		DATE	VALIDATION
Relever sur la base des données anamnestiques les facteurs du risque cardio-vasculaire			
Calculer l'index de pression systolique chez un artéritique			
Déceler par l'interrogatoire et l'examen physique les signes en faveur d'une artériopathie oblitérantes des membres inférieurs chez un patient se présentant pour des claudications intermittentes.			
Reconnaitre un trouble trophique chez un patient suivi pour artériopathie oblitérantes des membres inférieures			
Reconnaitre une douleur ischémique de repos chez un patient artéritique			
Réaliser un examen des pouls au niveau des membres inférieurs			
Reconnaitre une ischémie aigue chez un patient ayant une cardiopathie emboligène			
Énumérer les moyens thérapeutiques de l'ischémie aigue			
Reconnaitre à l'auscultation cardiaque un roulement diastolique de rétrécissement mitral			
Reconnaitre à l'auscultation cardiaque un souffle en rayon de roue de communication interventriculaire			
L'artériographie des membres inférieurs	Identifier les principales artères des membres inférieurs		
	Reconnaitre une occlusion sur une artériographie		
	Reconnaitre une sténose artérielle sur une artériographie		
	Décrire l'aspect des arcs de la silhouette cardiaque sur une radiographie thoracique de chez un patient porteur d'une valvulopathie mitrale au stade chirurgicale		
	Décrire l'aspect des arcs de la silhouette cardiaque sur et la vascularisation pulmonaire de chez un patient ayant une tétralogie de Fallot		
	Reconnaitre sur la radiographie du thorax chez patient opéré pour remplacement valvulaire mitral Les fils d'aciers ; les valves mécaniques		
	Interpréter une radiographie du thorax d'un patient porteur d'un shunt gauche droit		
ARC	Démarche diagnostique devant une claudication intermittente		
	Démarche diagnostique devant des œdèmes des membres inferieurs		
	Démarche diagnostique devant un gros membre inferieur		

Surveiller cliniquement un patient hospitalisé en USI en post opératoire de chirurgie cardiaque		
Rédiger l'observation d'un patient atteint d'AOMI		
Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour cardiopathie ischémique		

- Stage en 6ème année

OBJECTIF		DATE	VALIDATION
Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour une valvulaopathie au stade chirurgical			
Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour insuffisance cardiaque décompensée.			
Rédiger l'observation d'un patient hospitalisé pour varices MI			
Surveiller cliniquement un patient hospitalisé pour ischémie aigue MI			
Calculer l'index de pression systolique chez un artéritique			
Prescrire une ordonnance chez un patient atteint d'AOMI.			
Expliquer les moyens physiques de réadaptation chez un claudicant			
Prescrire une contention élastique veineuse			
Expliquer au patient sous antivitamine K le traitement, son but, les règles d'administration, les complications, la surveillance et le régime alimentaire			
Expliquer le régime hyposodé à un patient en insuffisance cardiaque			
Reconnaitre les artères coronaires sur une coronarographie normale			
ARC	Démarche diagnostique devant un ulcère de jambe		
	Démarche diagnostique devant des varices MI		
	Démarche diagnostique devant une masse battante abdominale		

SERVICE DE CHIRURGIE VASCULAIRE PÉRIPHÉRIQUE

- Stage en 4ème année

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Réaliser un examen vasculaire chez un patient polyvasculaire		
Poser le diagnostic d'une artériopathie oblitérante du membre inférieur		
Évaluer les autres localisations athéromateuses chez un patient polyvasculaire		
Reconnaitre cliniquement une ischémie aigue et critique du membre inférieur		
Poser le diagnostic d'un anévrysme de l'aorte abdominale		
Reconnaitre les signes cliniques en faveur de l'origine carotidienne d'un AVCI		
Évaluer les signes de gravité d'un traumatisme vasculaire chez l'adulte		
Poser le diagnostic d'une insuffisance veineuse		
Reconnaitre le principe du traitement endovasculaire		
Interpréter un examen radiologique de l'aorte, membre inférieur et TSA		
Assister aux différents types d'interventions pratiquées dans le service		

- Stage en 6ème année

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Rédiger un bilan préopératoire chez un patient polyvasculaire		
Reconnaitre les complications de l'artériopathie oblitérante du membre inférieur		
Assurer la surveillance post-opératoire d'un opéré en chirurgie vasculaire		
Reconnaitre le principe et complications des abords vasculaires pour hémodialyse		
Rédiger une ordonnance d'un opéré en chirurgie vasculaire		
Interpréter les différentes explorations radiologiques dans la pathologie de l'aorte abdominale et ses branches		
Expliquer le principe thérapeutique d'une insuffisance veineuse		
Poser le diagnostic d'un syndrome post-phlébitique.		

Séances d'ARC

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Élaborer une démarche diagnostique devant une claudication intermittente MI		
Élaborer une démarche diagnostique devant une artérite diabétique		
Élaborer une démarche diagnostique devant un gros membre inférieur		
Élaborer une démarche diagnostique devant un déficit moteur d'origine carotidienne		
Élaborer une démarche diagnostique devant une masse battante		

SERVICE DE CHIRURGIE VISCÉRALE

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Caractériser une douleur abdominale dans un contexte aigu.		
Reconnaître une défense abdominale chez un patient présentant une appendicite aigue.		
Reconnaitre un empattement abdominal chez un patient présentant un plastron appendiculaire.		
Reconnaître une contracture abdominale chez un patient présentant une péritonite aigue généralisée.		
Reconnaitre une sensibilité du cul de sac de douglas chez un patient présentant une péritonite.		
Reconnaitre un comblement du cul de sac de douglas chez un patient présentant un épanchement intra péritonéal.		
Faire un toucher rectal chez un patient présentant une tumeur rectale palpable.		
Reconnaître un météorisme abdominal chez un patient présentant une occlusion intestinale aigüe.		
Reconnaitre une hernie simple chez un patient présentant une tuméfaction pariétale.		
Reconnaitre une douleur d'origine biliaire chez un patient présentant une lithiase vésiculaire.		
Palper une grosse vésicule chez un patient présentant un ictère néoplasique.		
Reconnaitre une douleur d'origine pancréatique chez un patient présentant une pancréatite aigüe.		
Caractériser une masse abdomino-pelvienne palpable chez un adulte.		
Reconnaitre le caractère chirurgical d'un ictère chez un patient ictérique.		
Assurer le suivi postopératoire d'un patient opéré de l'abdomen.		
Reconnaitre une infection de la paroi chez un patient opéré de l'abdomen.		
Savoir poser le diagnostic d'un abcès devant une tuméfaction douloureuse de la marge anale.		
ARC : Démarche diagnostique devant une douleur abdominale aigue.		
ARC : Démarche diagnostique devant un ictère rétentionnel.		
ARC : Démarche diagnostique devant une hémorragie digestive haute.		
ARC : Démarche diagnostique devant une hémorragie digestive basse.		
ARC : Démarche diagnostique devant une occlusion intestinale aigüe.		
ARC : Démarche diagnostique devant une masse abdominale		

SERVICE DE TRAUMATOLOGIE-ORTHOPÉDIE

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Identifier les signes cliniques d'une fracture de membre chez un traumatisé adulte		
Identifier les signes cliniques d'une luxation chez un traumatisé adulte		
Rechercher une complication Vx Nx d'une fracture / luxation		
Faire un examen programmé du genou : testing méniscal et ligamentaire		
Reconnaître les différents stades de l'ouverture cutanée selon Cauchoix et Duparc chez un patient victime d'une fracture de jambe		
Examiner un patient présentant une tumeur des parties molles		
Examiner un patient présentant une tumeur osseuse (bénigne et maligne)		
Décrire une fracture sur un cliché radiographique standard		
Décrire une luxation sur un cliché radiographique standard		
Réaliser un appareil plâtré / réduction/ immobilisation		
Faire un parage de plaie		
Réduire une luxation de l'épaule		
Réduire et immobiliser une fracture		
Rechercher les signes radiologiques d'une tumeur osseuse		
Réaliser le bilan d'une tumeur de l'appareil locomoteur (clinique, biologie, imagerie)		
Identifier un syndrome de loge/ syndrome de Volkmann		
Rechercher une lésion tendineuse au cours d'une plaie de la main		
Rechercher une lésion nerveuse au cours d'une plaie de la main		
Faire l'examen clinique d'un patient présentant une infection de la main (un panaris, un phlegmon des gaines, ostéite)		
Faire le diagnostic (clinique et imagerie) d'une ostéomyélite chronique		
Identifier le matériel d'ostéosynthèse utilisé sur une radiographie de contrôle		
ARC : épaule traumatique		
ARC : genou traumatique		
ARC : cheville traumatique		
ARC : les complications d'une fracture (cal vicieux, pseudarthrose)		
ARC : membre opéré tuméfié et chaud (thrombophlébite, Infection du site opératoire)		

SERVICE DE NEUROCHIRURGIE

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Pratiquer un examen neurologique chez l'adulte		
Pratiquer un examen neurologique chez l'enfant		
Évaluer le score de Glasgow chez un patient ayant des troubles de conscience		
Évoquer le diagnostic d'un syndrome cérébelleux chez un patient présentant des troubles de l'équilibre		
Reconnaitre les signes cliniques d'une hypertension intracrânienne chez un patient céphalalgique		
Reconnaitre les signes cliniques d'un engagement cérébral temporal chez un patient présentant un processus occupant expansif		
Reconnaitre les signes cliniques d'un engagement cérébral amygdalien chez un patient présentant un processus occupant expansif		
Reconnaitre un syndrome de compression médullaire chez un patient présentant une impotence fonctionnelle des membres		
Reconnaitre une sciatique et préciser sa topographie chez un patient présentant des douleurs des membres inférieurs		
Reconnaitre une névralgie cervico-brachiale chez un patient ayant des douleurs aux membres supérieurs		
Reconnaitre un spina Bifida chez un nouveau-né présentant une masse médiane lombosacrée		
Reconnaitre les signes cliniques d'une hémorragie méningée spontanée chez un patient présentant des céphalées		
Reconnaitre les signes cliniques d'une hydrocéphalie chez un nourrisson		
Distinguer sur le scanner cérébral un AVC ischémique d'un AVC hémorragique chez un patient présentant une hémiplégie aigue		

Distinguer sur un scanner cérébral les signes de malignité d'une tumeur cérébrale		
Identifier sur un scanner cérébral les signes d'une tumeur cérébrale bénigne		
Relever les signes radiologiques sur un scanner cérébral d'un patient ayant une suppuration intracrânienne		
Effectuer une ponction lombaire chez un patient ayant un syndrome méningé		
Interpréter une radiographie du rachis cervical, dorsal et lombosacré chez un traumatisé du rachis		
Réaliser le ramassage d'un polytraumatisé		
Mettre en place un collier ou une minerve chez un traumatisé du rachis cervical		
Mettre en place un lombostat chez un patient ayant une pathologie du rachis lombaire		
Réaliser des points de sutures d'une plaie du scalpe post traumatique		
Faire un lavage antiseptique des mains avant tout geste de soins		
Conduite à tenir devant une paraplégie (ARC)		
Conduite à tenir devant une hémiplégie (ARC)		
Conduite à tenir devant une Hypertension Intracrânienne (HTIC) (ARC		
Conduite à tenir devant des vertiges(ARC)		

SERVICE D'ORL

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Pratiquer une otoscopie chez un patient présentant une otalgie		
Pratiquer une rhinoscopie antérieure chez patient ayant obstruction nasale		
Pratiquer une laryngoscopie indirecte chez un patient présentant une dysphonie chronique		
Réaliser un méchage antérieur chez un patient se présentant pour une épistaxis de moyenne abondance		
Rédiger une ordonnance pour une otite aigue chez l'enfant		
Réaliser une acoumétrie instrumentale chez un patient ayant une hypoacousie		
Pratiquer l'examen des différentes aires ganglionnaires du cou d'un patient ayant un cancer ORL		
Réaliser un examen du cou chez un patient ayant un nodule thyroïdien		
Réaliser un examine de la Cavité buccale et de l'oropharynx		
Rédiger une ordonnance pour une sinusite aigue de l'adulte		
Explorer cliniquement les différentes paires crâniennes		
Reconnaître une dyspnée laryngée de l'adulte et l'enfant		
Reconnaitre à l'otoscopie les aspects tympaniques d'une OMC		
ARC : Surdité		
ARC : Obstruction Nasale		
ARC : Vertiges		
ARC : Dysphonie		
ARC : Masse cervicale		
ARC : Epistaxis		

SERVICE D'OPHTALMOLOGIE

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Mesurer l'acuité visuelle chez un adulte consultant pour BAV		
Reconnaitre un strabisme chez un enfant		
Réaliser un fond d'œil chez un patient diabétique		
Rechercher le réflexe photo-moteur chez un patient suivi pour une neuropathie optique		
Reconnaitre un œdème papillaire chez une patiente consultante pour tableau d HTIC		
Apprécier aux doigts le tonus oculaire chez un sujet normal		
Réaliser un examen de l'oculomotricité chez un traumatisé de l'orbite		
Réaliser l'étude du champ visuel au doigt chez un patient présentant un adénome hypophysaire		
Réaliser un lavage oculaire á la suite d'une brulure chimique oculaire		
Instiller un collyre cycloplégique pour dilatation oculaire		
Reconnaitre une leucocorie chez un enfant consultant pour strabisme		
Chercher les signes de gravite d'un traumatisme oculaire		
Expliquer les règles de l'hygiène au cours d'une conjonctivite infectieuse		
Éduquer et informer un patient glaucomateux sur l'observance du traitement antiglocomateux		
ARC : Œil rouge		
ARC : Leucocorie de l'enfant		
ARC : Exophtalmie		
ARC : Strabisme de l'enfant		
ARC : Diplopie chez l'adulte		
ARC : Traumatisme cranio-facial, Baisse brutale de l'acuité visuelle		

SERVICE D'UROLOGIE

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Reconnaitre un contact lombaire chez un patient avec un gros rein		
Reconnaitre un ballottement rénal chez un patient avec un gros rein		
Reconnaitre une crise de coliques néphrétiques chez un patient admis aux urgences		
Identifier les signes de gravités imposant une hospitalisation chez un patient présentant une crise de colique néphrétique		
Reconnaitre une pyélonéphrite aigue simple chez une femme jeune		
Recueillir les symptômes et signes physiques les plus utiles au diagnostic étiologique de la dysurie		
Reconnaître un globe vésical chez un patient présentant une rétention aigue d'urines		
Distinguer une réelle hématurie macroscopique d'une anomalie de coloration d'urine due à des facteurs autres qu'un saignement urinaire (fausse hématurie)		
De recueillir et d'interpréter les symptômes et signes physiques en vue du diagnostic étiologique d'une hématurie		
Évoquer le diagnostic d'une prostatite aigue devant un patient présentant des troubles mictionnels fébriles		
Évoquer le diagnostic de cancer de prostate devant des anomalies au toucher rectal		
Recueillir les signes physiques permettant d'évoquer le diagnostic d'un cancer du testicule chez un jeune qui présente une grosse bourse		
Identifier les éléments en faveur d'une torsion du cordon spermatique chez un jeune patient consultant pour une douleur scrotale aigue		
Distinguer, à l'examen physique, les tuméfactions scrotales de celles qui proviennent du canal inguinal (anomalies du canal péritoneo-vaginal / hernie inguino-scrotale)		
Distinguer, à l'examen physique, une grosse bourse en rapport avec une masse solide (tumeur) d'une grosse bourse en rapport avec une masse liquidienne (hydrocèle)		
Proposer les examens complémentaires utiles pour le diagnostic étiologique d'une grosse bourse chronique chez un patient en consultation		
Reconnaître les éléments sémiologiques d'une infection urinaire non compliquée chez une femme		

Distinguer cliniquement une incontinence urinaire d'une fistule vésico vaginale chez une femme présentant des fuites d'urines		
Effectuer un sondage urinaire chez un homme en rétention aigue d'urines		
Identifier à l'anamnèse et à l'examen clinique les éléments contre-indiquant un sondage urinaire chez l'homme (traumatisme du bassin, prostatite aigue, sténose de l'urètre)		
Reconnaître les éléments en faveur d'un traumatisme rénal chez un poly-traumatisé admis aux urgences		
Reconnaître sur un cliché d'arbre urinaire sans préparation une opacité de tonalité calcique orientant vers un calcul urinaire chez un patient présentant une crise colique nephretique		
Réaliser un prélèvement d'urine pour examen cytobactériologique chez une ou un patient hospitalisé		
Interpréter un examen cytobactériologique des urines chez un patient présentant une infection urinaire ;		
ARC : Troubles mictionnels chez le sujet âgé		
ARC : Hématurie macroscopique		
ARC : Lombalgies		
ARC : Grosses bourses		

SERVICE DE STOMATOLOGIE ET CHIRURGIE MAXILLO-FACIALE

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Examiner une face normale (patient simulé). Examiner un patient présentant un traumatisme nasal. Examiner un patient présentant un traumatisme mandibulaire. Examiner un patient présentant un traumatisme orbito-zygomatique. Examiner un patient présentant un fracas de la face (Donef/ séparations). Pratiquer un examen ganglionnaire cervical chez un patient porteur d'une tumeur oro-faciale Classer les fentes labio-alvéolopalatines sur base de données Iconographiques.		
Reconnaitre les signes de bénignité d'une tumeur du maxillaire sur un OPT.		
Reconnaitre les signes de malignité d'une tumeur du maxillaire sur un OPT.		
Interpréter un OPT d'un patient présentant une fracture mandibulaire.		
Prescrire une imagerie chez un enfant traumatisé de la face.		
Interpréter une TDM d'un traumatisme de la face.		
Interpréter une TDM d'un patient porteur d'un cancer oro-faciale.		
Éduquer un patient candidat à une radiothérapie des VADS		

ARC

CAT devant : « démarche diagnostic et thérapeutique »

1) Traumatisme de la face

2)- Limitation de l'ouverture buccale (diagnostic).

3)- Tuméfaction latéro-faciale (diagnostic).

4)- Cellulite d'origine dentaire (PEC et traitement).

5)- Malformation cranio-faciale (de la naissance à l'âge adulte).

Activité d'exposition adjuvantes :

Pratiquer des points de sutures faciales aux urgences.

SERVICE DE CHIRURGIE PLASTIQUE

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Savoir poser le diagnostic clinique de profondeur, d'étendue d'une brûlure		
Réaliser les gestes de 1er secours chez les brûlés		
Poser l'indication d'une hospitalisation d'un patient brûlé		
Reconnaître les différentes phases de cicatrisation : détersion, bourgeonnement, épidermisation		
Indiquer le pansement adapté pour chaque phase de cicatrisation		
Décrire à l'examen clinique d'un patient, les principales séquelles de brûlure		
Reconnaître sur l'examen clinique des patients, les quatre stades des escarres		
Réaliser les soins locaux adaptés de chaque type d'escarre		
Rédiger une ordonnance pour la prise en charge sur le plan général, d'un patient porteur d'escarre		
Reconnaître à l'examen clinique d'un patient, une infection cutanée chirurgicale		
Reconnaître les malformations congénitales faciales, des membres et du sein les plus fréquentes		
Décrire, en assistant au bloc opératoire, les grands principes des différentes techniques de couverture des pertes de substance cutanées		
ARC : démarche diagnostique devant une tumeur cutanée et des parties molles		
ARC : démarche diagnostique devant une infection des parties molles		

Objectifs pratiques du stage de chirurgie réparatrice et plastique

GESTES	DATE	VALIDATION
Réfection de pansement d'un petit brûlé		
Réfection de pansement d'un patient opéré		
Réaliser des sutures cutanées		
Faire le lavage et l'habillage chirurgical		
Faire une biopsie d'une petite lésion cutanée		
Faire le diagnostic clinique de profondeur, d'étendue d'une brûlure		

SERVICE DE GYNÉCOLOGIE OBSTÉTRIQUE

- Stage en 5ème année

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Mesurer avec précision la hauteur utérine chez une patiente enceinte au 3ème trimestre		
Reconnaître le type de présentation fœtale chez une parturiente en travail		
Mener un counseling chez une femme qui consulte pour suivi de grossesse		
Reconnaître un globe utérin de « sécurité » cher une parturiente en post-partum immédiat		
Mettre en place un spéculum chez une patiente qui consulte pour métrorragies		
Reconnaître un col normal à l'examen au spéculum		
Apprécier la taille de l'utérus par un toucher vaginal chez une patiente en dehors de la grossesse		
Préciser les caractéristiques d'une masse latéro-utérine au toucher vaginal		
Réaliser un examen des seins		

- Stage en 6ème année

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Réaliser un accouchement normal en présentation céphalique chez une parturiente à terme		
Effectuer une délivrance normale après un accouchement par voie basse		
Effectuer une épisiotomie médio-latérale lors d'un accouchement en présentation céphalique		
Réaliser la réfection d'une épisiotomie après un accouchement normal		
Réaliser un partogramme chez une parturiente en travail en salle d'accouchement		
Mettre en place une perfusion d'ocytociques pour activation de travail chez une parturiente en salle d'accouchement		
Réaliser une révision utérine chez une patiente ayant une hémorragie de la délivrance		
Poser le diagnostic de menace d'accouchement prématuré chez une patiente se présentant pour contractions utérines		

Conduire un traitement tocolytique de 1ère intention chez une patiente ayant une menace d'accouchement prématuré		
Faire le diagnostic d'une hémorragie du post partum immédiat chez une parturiente qui saigne après accouchement par voie basse		
Évaluer la gravité d'une hémorragie du post partum immédiat chez une parturiente qui saigne après accouchement par voie basse		
Réaliser un enregistrement cardio-tocographique chez une femme enceinte à terme		
Interpréter un enregistrement cardio-tocographique chez une femme enceinte à terme		
Insérer un stérilet sur mannequin		
Retirer un stérilet chez une femme en activité génitale ou sur un mannequin		
Réaliser un frottis cervico-vaginal chez une patiente en activité génitale		
SÉANCES D'ARC		
CAT devant HTA gravidique		
CAT devant hémorragie du 1er trimestre de grossesse		
CAT devant une Masse Latéro-Utérine		
CAT devant une hémorragie du 3ème trimestre de grossesse		

F- Les objectifs des stages hospitaliers dans les services de L'enfant

SERVICES DE L'ENFANT

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
NÉONATOLOGIE		
Évaluer le score de Silverman chez le nouveau-né.		
Mesurer la fréquence respiratoire et cardiaque du nouveau-né.		
Évaluer le Score d'Apgar à la première, la cinquième et la dixième minute de vie chez un nouveau-né en salle de naissance.		
Dépister une atrésie de l'œsophage chez un nouveau-né en salle de naissance.		
Dépister une atrésie des choanes chez un nouveau-né en salle de naissance.		
Dépister une imperforation anale chez un nouveau-né en salle de naissance.		
Rédiger l'ordonnance des soins des yeux, de l'ombilic et la vitamine K du nouveau-né à terme.		
Calculer l'âge gestationnel selon les scores morphologiques chez un nouveau-né prématuré.		
Mesurer la glycémie capillaire chez un nouveau-né à risque d'hypoglycémie.		
Reconnaître une hypotrophie à partir des mensurations du nouveau-né selon les courbes de référence.		
Suspecter sur l'anamnèse le degré du risque infectieux chez le nouveau-né.		
Prescrire une antibiothérapie probabiliste de l'infection néonatale adaptée.		
Reconnaître et évaluer le degré d'une souffrance néonatale selon le score de Sarnat.		
Traiter des convulsions chez un nouveau-né.		
PÉDIATRIE		
Faire l'examen clinique d'un enfant normal « dossier médical ».		
Expliquer les modalités de l'allaitement maternel.		
Expliquer les modalités de la diversification alimentaire.		
Expliquer les étapes du calendrier vaccinal d'un enfant aux parents.		
Établir une courbe de croissance pondérale et staturale.		
Évaluer le développement psychomoteur d'un nourrisson.		
Évaluer l'état nutritionnel d'un enfant.		
Expliquer l'intérêt du carnet de santé pour le suivi d'un enfant.		

Mesurer la TA d'un enfant et l'interpréter en fonction des courbes de référence.		
Réaliser l'examen des urines par des bandelettes.		
Reconnaître une convulsion du nourrisson.		
Reconnaître la lésion élémentaire d'une éruption de l'enfant.		
Interpréter un ECBU chez l'enfant suspect d'infection urinaire.		
Reconnaître une raideur méningée chez un enfant fébrile.		
Réaliser une ponction lombaire chez un enfant.		
Interpréter les résultats du LCR d'un enfant.		
Reconnaitre une crise d'asthme chez un enfant.		
Évaluer la gravité d'une crise d'asthme chez un enfant.		
Évaluer la gravité d'une déshydratation aiguë.		
Reconnaître les signes évocateurs d'une cardiopathie congénitale.		
Évaluer la gravité d'une acidocétose diabétique chez un enfant.		
Interpréter un hémogramme chez l'enfant.		
Reconnaître une paralysie flasque aigue devant une impotence fonctionnelle.		
SÉANCES D'ARC : Établir une démarche diagnostique devant ○ une diarrhée chronique. ○ une fièvre, ○ une dyspnée. ○ des vomissements chroniques. ○ des douleurs abdominales. ○ une hématurie / protéinurie ○ une fièvre prolongée. ○ un syndrome œdémateux. ○ une anémie / Pâleur.		
CHIRURGIE PÉDIATRIQUE		
Examiner l'abdomen douloureux d'un enfant.		
Examiner l'appareil uro-génital de l'enfant.		
Examiner l'appareil locomoteur d'un enfant.		
Examiner un rachis douloureux ou déformé chez l'enfant.		
Rechercher les complications vasculo-nerveuses lors d'une fracture chez l'enfant.		
Savoir dépister en période néonatale une atrésie de l'œsophage.		

Savoir dépister en période néonatale une malformation ano-rectale.		
Savoir dépister en période néonatale une luxation congénitale de hanche.		
Savoir dépister en période néonatale une Paralysie obstétricale du plexus brachial.		
Savoir dépister en période néonatale les autres anomalies orthopédiques et viscérales apparentes.		
Reconnaître les attitudes vicieuses articulaires.		
Reconnaître un flessum extra-articulaire.		
Reconnaître une scoliose structurale, une raideur rachidienne.		
Reconnaître un syndrome de loges chez un enfant traumatisé.		
Reconnaître les anomalies du canal péritonéo-vaginal.		
Reconnaître une ectopie testiculaire.		
Inciser un abcès des parties molles chez l'enfant.		
Réaliser des sutures cutanées chez l'enfant.		
Réaliser un sondage vésical chez l'enfant.		
Réaliser un cathétérisme œsophagien chez un nouveau-né.		
Réaliser un lavement évacuateur chez l'enfant.		
Réaliser une ponction et/ou un drainage pleural chez l'enfant.		
Participer à une consultation de chirurgie pédiatrique.		
Accueillir les parents d'un malade.		
Participer à une intervention chirurgicale chez l'enfant.		
Surveiller un enfant opéré.		
Éduquer un enfant admis pour maladie hydatique.		
SÉANCES D'ARC : Mener une démarche diagnostique devant : **a.** Une boiterie de l'enfant **b.** Un enfant traumatisé **c.** Une masse abdomino-pelvienne de l'enfant **d.** Une douleur abdominale aigue de l'enfant **e.** Une choléstase néonatale **f.** Une occlusion néonatale		

RADIOLOGIE PÉDIATRIQUE			
Imagerie De l'enfant	Interpréter un ASP chez le nouveau-né.		
	Interpréter une radiographie thoracique chez l'enfant.		
	Reconnaitre un reflux vésico-urétérale et sa stadification sur un UCG chez un enfant.		
	Relever les signes d'ostéo-chondrite primitive de hanche sur la radiographie de hanche de l'enfant.		
	Déceler les signes d'une LCH sur une radiographie du bassin chez un nourrisson de 4 mois.		

SERVICE DE RÉANIMATION PÉDIATRIQUE

OBJECTIF DU STAGE	DATE	VALIDATION
Réaliser un lavage simple et une friction hydro-alcoolique des mains		
Pratiquer un massage cardiaque externe et une défibrillation chez un enfant en arrêt cardio-respiratoire		
Libérer les voies aériennes chez un enfant comateux		
Mettre en place une oxygénothérapie chez un enfant en détresse respiratoire (lunettes et masques)		
Pratiquer une aspiration bucco pharyngée et trachéale chez un enfant intubé		
Pratiquer une ventilation à l'aide d'un ballon auto-remplisseur chez un enfant		
Mettre en place une sonde naso-gastrique chez un enfant		
Poser une voie veineuse périphérique chez un enfant		
Réaliser un prélèvement sanguin et urinaire à visée diagnostique ou microbiologique chez un enfant		
Identifier sur un ionogramme sanguin les principaux troubles hydro-électrolytiques chez un enfant		
Reconnaître sur la gazométrie artérielle un désordre acido-basique élémentaire d'un enfant en détresse vitale		
Interpréter une radiographie thoracique faite au lit d'un enfant intubé		
Réaliser un bilan hydrique entrées/sorties chez un enfant		
Mesurer par le dextrostix la glycémie capillaire chez un enfant comateux ou sédaté		
Conduire une transfusion sanguine chez un enfant en état de choc hémorragique		
Mettre en route un traitement à base de catécholamines chez un enfant en état de choc		

Participer à la gestion d'un transport médicalisé en intra-hospitalier d'un enfant		
Installer un monitorage de base chez un enfant		
Accueillir la famille d'un enfant admis en réanimation		
Evaluer la douleur aigue chez un enfant et un nourrisson		
Rédiger une ordonnance au profit d'un enfant se plaignant d'une douleur post-opératoire		
Assister au déroulement d'une anesthésie générale chez un enfant		
Assister au déroulement d'une anesthésie loco-régionale chez un enfant		

G- Les objectifs spécifiques des stages dans les services de réanimation

SERVICE DE RÉANIMATION ANESTHÉSIE

Thèmes Cardio-circulatoires :

OBJECTIF DU STAGE	DATE	VALIDATION
Reconnaitre et Évaluer un état de choc en réanimation		
Pratiquer un massage cardiaque et une défibrillation chez un patient en arrêt cardio-respiratoire		
Conduire un traitement à base de catécholamines chez un patient en état de choc en réanimation		
Conduire une transfusion sanguine chez un patient en choc hémorragique		

Thèmes respiratoires :

OBJECTIF DU STAGE	DATE	VALIDATION
Libérer les voies aériennes chez un patient inconscient en réanimation		
Mettre en place une oxygénothérapie chez un patient en détresse vitale : lunettes et masques		
Pratiquer une aspiration bucco pharyngée et trachéale chez un malade en réanimation		
Pratiquer une ventilation à l'aide d'un ballon auto-remplisseur chez un malade en réanimation		
Interpréter une radiographie thoracique faite au lit en réanimation		
Assister à une intubation orotrachéale chez un patient en détresse respiratoire		
Reconnaître les signes de gravité d'une insuffisance respiratoire aiguë chez un malade en détresse respiratoire en réanimation		

Thèmes métaboliques :

OBJECTIF DU STAGE	DATE	VALIDATION
Réaliser un bilan hydrique entrées/sorties des 24H chez un patient en réanimation		
Placer une sonde vésicale chez un patient en réanimation		
Placer une sonde gastrique chez un malade inconscient en réanimation		
Reconnaître sur la gazométrie artérielle un désordre acido-basique élémentaire d'un malade en réanimation		
Réaliser la glycémie capillaire chez un patient en réanimation		
Conduire une insulinothérapie chez un patient en réanimation		

Thèmes neurologiques :

OBJECTIF	DATE	VALIDATION
Réaliser un examen neurologique d'un patient comateux en réanimation		
Interpréter l'analyse du LCR d'un malade hospitalisé en réanimation pour une méningite		
Reconnaitre les signes cliniques de la mort encéphalique chez d'un malade en réanimation		

Thèmes infectieux :

OBJECTIF DU STAGE	DATE	VALIDATION
Reconnaitre un état septique grave chez un patient fébrile en réanimation		
Réaliser un lavage des mains et friction hydro-alcoolique		

Thèmes généraux :

OBJECTIF DU STAGE	DATE	VALIDATION
Pratiquer un monitorage standard d'un malade en réanimation		
Accueil des familles en réanimation		
Conduite et surveillance d'une Analgésie postopératoire en réanimation		
Surveillance d'un opéré de chirurgie lourde en réanimation		
Prise en charge des troubles de conscience (ARC)		
Prise en charge d'un état de choc en réanimation (ARC)		
Prise en charge d'une fièvre d'un malade en réanimation (ARC)		
Prise en charge des convulsions tonico-cloniques généralisées (ARC)		

H- Les objectifs spécifiques des stages dans les Laboratoires

SERVICE DE PARASITOLOGIE

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Expliquer au patient les conditions nécessaires à la réalisation d'un prélèvement des selles pour la recherche des parasites coprologiques.		
Interpréter un compte rendu d'un examen parasitologique des selles à la recherche d'amibes pathogènes et non pathogènes.		
Respecter la phase pré-analytique pour les prélèvements destinés à la sérologie parasitaire et fongique.		
Préciser les renseignements épidémio- cliniques justifiant la demande de la recherche de Plasmodium. sp devant la suspicion d'un accès palustre.		
Interpréter une sérologie toxoplasmique chez une femme enceinte.		
Surveiller sérologiquement l'évolution d'un kyste hydatique opéré et l'efficacité du traitement.		
Reconnaître les éléments en faveur de l'origine fongique d'une otite chronique.		
Savoir prescrire un examen mycologique devant une suspicion d'une mycose superficielle.		

SERVICE DE MICROBIOLOGIE

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Reconnaître les motifs de non-conformité pour un prélèvement à visée cytobactériologique.		
Rédiger convenablement une fiche d'examen pour un prélèvement effectué pour le diagnostic d'une infection bactérienne.		
Interpréter un examen cytobactériologique urinaire chez une patiente présentant des brûlures mictionnelles.		
Interpréter le résultat d'une coproculture réalisé devant une diarrhée aigue.		
Interpréter le résultat d'un examen cytobactériologique du LCR chez un patient hospitalisé pour une suspicion d'une méningite.		
Interpréter une sérologie hépatique chez un patient admis pour suspicion d'une hépatite virale.		
Interpréter une sérologie syphilitique chez un patient se présentant pour un don de sang.		
Interpréter une sérologie de la rubéole chez une femme enceinte.		

SERVICE D'ANATOMO-PATHOLOGIE

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Rédiger convenablement une demande d'examen anatomopathologique.		
Reconnaitre les motifs de non-conformité d'un examen anatomopathologique.		
Suivre le circuit d'une pièce opératoire en Anatomie pathologique.		
Interpréter un compte rendu anatomopathologique.		
Réaliser un Frottis cervico-vaginal dans le cadre du dépistage du cancer du col utérin.		
Séances d'ARC : Adénopathie cervicale chez un sujet jeune. Nodule mammaire. FCV anormal. Masse accouchée par le col utérin.		

SERVICE D'IMMUNOLOGIE

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Savoir les étapes de la phase pré-analytique relatives aux examens immunologiques de laboratoire.		
Interpréter une technique d'agglutination.		
Reconnaître les principaux aspects d'anticorps antinucléaires sur des lames d'immunofluorescence indirecte.		
Interpréter le bilan immunologique d'une maladie de système.		
Reconnaître un état de déficit immunitaire à partir d'un bilan biologique.		

SERVICE DE GÉNÉTIQUE

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Reconnaitre les principales indications cliniques du caryotype constitutionnel post-natal.		
Reconnaitre l'intérêt et les indications d'une consultation de conseil génétique.		
Reconnaitre un syndrome dysmorphique et ou malformatif.		
Reconnaitre une déficience mentale d'origine génétique.		
Savoir le bilan génétique de première intention à demander devant une anomalie de la différenciation sexuelle.		
Reconnaitre les principaux syndromes chromosomiques (La trisomie 21 et le syndrome de Turner).		

SERVICE DE BIOCHIMIE

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Citer le panel des paramètres biochimiques traités au laboratoire.		
Reconnaître les non-conformités d'un prélèvement sanguin pour analyse biochimique.		
Déduire les conséquences des non-conformités d'un prélèvement sanguin pour analyse biochimique		
Interpréter les résultats d'une gazométrie.		
Interpréter un bilan rénal.		
Interpréter un bilan hépatique.		
Interpréter un bilan lipidique.		
Interpréter un bilan phosphocalcique.		
Interpréter un protidogramme.		
Citer les principales indications de l'électrophorèse des protéines.		

SERVICE D'HÉMATOLOGIE

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Interpréter le résultat d'un hémogramme.		
Argumenter les hypothèses diagnostiques devant les principales anomalies de l'hémogramme.		
Élaborer la démarche diagnostique devant un allongement isolé du TCA.		
Argumenter les hypothèses diagnostiques devant un allongement du TCA.		
Élaborer la démarche diagnostique devant un allongement isolé du TP.		
Argumenter les hypothèses diagnostiques devant un allongement du TP.		
Élaborer la démarche diagnostique devant un allongement commun du TP et du TCA.		
Interpréter un groupage sanguin.		

I- Les objectifs spécifiques des stages dans les centres de santé

CENTRE DE SANTE

OBJECTIFS DU STAGE	DATE	VALIDATION
Connaitre l'organisation et les rôles de la direction régionale de santé et de la délégation		
Connaitre l'organisation et les rôles du SIAAP		
Connaitre l'organisation et les rôles du Centre de santé		
Assurer la prise en charge des affections courantes et délivrer une ordonnance thérapeutique		
Mettre à jour un carnet de santé d'un patient		
Connaître les différents programmes de santé publique : modalité de prise en charge, algorithmes, médicaments disponibles		
Connaître les outils du système d'information sanitaire		
Proposer et indiquer un moyen de contraception selon les différentes situations cliniques		
Mettre en place un stérilet		
Enlever un stérilet		
Surveiller cliniquement et biologiquement une grossesse au 1er, 2ème et 3ème trimestre		
Vacciner et surveiller un enfant vacciné		
Participer à la lutte contre les carences (vit A, vit D, fer, Iode)		
Assurer la prise en charge d'un patient diabétique		
Assurer la prise en charge d'un patient hypertendu		
Assurer la prise en charge d'un patient atteint de tuberculose		
Assurer la prise en charge d'un patient asthmatique		
Assurer la prise en charge d'une Infection Sexuellement Transmissible		
Mener l'éducation d'un patient atteint d'hypertension artérielle		
Mener l'éducation d'un patient diabétique		
Mener l'éducation d'un patient atteint d'asthme		
Participer au processus de la surveillance épidémiologique		
Reconnaître les maladies à déclaration obligatoire et participer à leurs déclarations		
Pratiquer l'intradermo réaction à la tuberculine (IDR)		
Lire une IDR à la tuberculine		

J- Annexes

Annexe 1: charte du stage hospitalier

Les stages hospitaliers constituent la principale composante de la formation pratique des étudiants en médecine. Ils se déroulent dans les services de soins du Centre Hospitalier Universitaire Mohamed VI et de l'Hôpital Militaire Avicenne (HMA), sous la responsabilité conjointe du Directeur du Centre Hospitalier Universitaire, du Médecin chef de l'HMA (représentés par les chefs des services hospitaliers) et du Doyen de la Faculté de Médecine.

En plus de la participation à la vie active du service, l'étudiant doit acquérir les objectifs nécessaires à la pratique médicale courante ; ces objectifs sont contenus dans la liste spécifique à chaque service remise à l'étudiant au début du stage.

Le carnet de stage est un élément du livret de l'étudiant. Il doit être soigneusement rempli durant toute la durée de l'externat. Toute falsification expose l'étudiant à des sanctions graves.

Cette charte, élaborée par les membres du comité de stage hospitalier, a pour objectif de clarifier droits, devoirs, activités hospitalières, modalités de formation et d'évaluation des étudiants lors des stages hospitaliers.

A. L'étudiant :

- Il est acteur et responsable de sa formation.
- Toute demande de stage au niveau du CHU par les étudiants étrangers doit avoir l'accord préalable du Doyen de la Faculté de Médecine et du directeur du CHU et de l'HMA.
- L'étudiant bénéficie d'un accueil personnalisé et d'une visite de la structure. Un livret d'accueil lui est remis au début de stage.
- L'étudiant est considéré comme une personne en formation.
- L'étudiant bénéficie d'un encadrement par une équipe pluridisciplinaire et par un référent de stage qui a comme mission de l'aider à atteindre ses objectifs.
- Il est évalué en fin de stage.
- S'engage à respecter les modalités d'organisation du stage ;
- Formule les objectifs en cohérence avec le livret d'accueil et son niveau d'acquisition figurant dans le portfolio qu'il présente, complète et fait valider par le tuteur ;
- Intègre une démarche constructive d'apprentissage : il se donne les moyens d'acquérir des compétences à partir des ressources mises à disposition dans le service ;

- S'inscrit dans une logique de réflexion d'analyse de pratique ;
- Adopte un comportement responsable, attentif aux personnes et aux biens ;
- Est respectueux de la réglementation, des règles professionnelles, ainsi que des règles en vigueur dans la structure d'accueil.

B. <u>Le Lieu du stage :</u>

- Les stages se déroulent dans les différents services hospitaliers du CHU Mohamed VI et de l'HMA selon un planning préétabli par la Faculté de Médecine.
- Les affectations ne peuvent être modifiées qu'après avis favorable du Doyen de la Faculté de Médecine.
- La demande de stage à l'étranger se fait auprès du Doyen de la Faculté de Médecine en coordination avec le service d'accueil à l'étranger.

C. <u>Les responsables de l'encadrement :</u>

1. Le chef de service :

- Il est responsable de l'organisation du stage.
- Met en place les moyens nécessaires à l'encadrement.
- Il est garant de la qualité de l'encadrement et de l'évaluation.

2. Le référent de stage :

Le référent de stage soignant exerçant les fonctions d'encadrement, est responsable de l'organisation du stage et s'engage à :

- Accueillir l'étudiant lors de son arrivée
- Lui présenter son tuteur de stage
- Les professionnels de proximité présents
- Organiser une visite du service
- Mettre en place les moyens nécessaires à l'encadrement : nommer des professionnels de proximité au quotidien en fonction du planning du service et des objectifs de l'étudiant
- Être garant de la qualité de l'encadrement

- Assurer les relations avec l'Institut de Formation

- Régler les questions en cas de difficultés ou de conflits

- Participer à l'évaluation des étudiants

- Prévenir la faculté pour toutes difficultés éventuelles ou problèmes survenant pendant la période de stage (accident, absences).

3. Les enseignants du service :

- Sont responsables de l'encadrement.

- Ils aident l'étudiant dans l'acquisition des compétences.

4. **Le tuteur de stage :**

- Représente la fonction pédagogique du stage. Il peut le faire temporairement et sur une zone à délimiter (pôle, unité...) ;

- Est un professionnel expérimenté, il a développé des capacités ou des compétences spécifiques et de l'intérêt pour l'encadrement d'étudiants ;

- Connaît bien les référentiels d'activités, de compétences et de formation des futurs professionnels qu'il encadre ;

- Assure un accompagnement des étudiants et évalue leur progression lors d'entretiens réguliers ;

- Peut accompagner plusieurs étudiants et les recevoir ensemble lors de leur accueil ou de séquences de travail ;

- Peut proposer aux étudiants, des échanges autour des situations ou des questions rencontrées ;

- Facilite l'accès des étudiants aux divers moyens de formation proposés sur les lieux de stage, les met en relation avec des personnes ressources et favorise, en liaison avec le maître de stage, l'accès aux services collaborant avec le lieu de stage en vue de comprendre l'ensemble du processus de soin ;

- A des relations régulières avec le formateur de l'institut de formation, référent du stage. Il propose des solutions en cas de difficultés ou de conflits ;

- Évalue la progression des étudiants dans l'acquisition des compétences

après avoir demandé l'avis des professionnels qui ont travaillé en proximité avec l'étudiant ;

- Formalise cette progression sur le portfolio lors des entretiens avec l'étudiant en cours et à la fin du stage. Chaque étudiant connaît son tuteur de stage et ses missions.

4. Les résidents et les internes :

- Contribuent à l'encadrement sous la supervision du chef de service
- Peuvent s'être nommés comme des tuteurs

5. Les professionnels de proximité :

- Représentent la fonction d'encadrement pédagogique au quotidien ;
- Sont présents avec l'étudiant lors des séquences de travail de celui-ci, le guident de façon proximale, lui expliquent les actions, nomment les savoirs utilisés, rendent explicites leurs actes, etc.... ;
- Accompagnent l'étudiant dans sa réflexion et facilitent l'explicitation des situations et du vécu du stage, ils l'encouragent dans ses recherches et sa progression ;
- Consultent le port folio de l'étudiant afin de cibler les situations, activités ou soins devant lesquels l'étudiant pourra être placé ;
- Ont des contacts avec le tuteur afin de faire le point sur l'encadrement de l'étudiant de manière régulière ;
- Plusieurs personnes peuvent assurer ce rôle sur un même lieu de travail en fonction de l'organisation des équipes. Les autres professionnels de santé contribuent aux apprentissages de l'étudiant.

D. <u>Le déroulement du stage :</u>

1. L'accueil de l'étudiant :

L'accueil est organisé par le chef de service ou le référent de stage, afin de :

- Présenter les structures, les activités et les différentes particularités du service
- Présenter le personnel médical et paramédical pour favoriser l'intégration au sein du service.

2. Le représentant du groupe des étudiants :

- Un représentant du groupe est choisi par les étudiants.
- Il a un rôle d'intermédiaire entre le groupe et le responsable du stage.
- Il doit transmettre les doléances et requêtes des étudiants au responsable du stage

3. L'activité hospitalière :

- L'étudiant est chargé de la tenue du dossier médical.
- Il accomplit les tâches qui lui sont confiées par le responsable de stage.
- Il doit avoir son matériel : stéthoscope, marteau à réflexe, torche, abaisse-langue, mètre ruban…
- Il doit valider les objectifs du stage hospitalier contenus dans le carnet de stage **;**
- Il doit participer à la vie du service, sous la direction du chef de service et du personnel médical et enseignant. Cette activité consiste en :
    - La rédaction de l'observation **médicale qui doit comporter :**
    - Le recueil des données fournies par l'interrogatoire et l'examen clinique complet du malade, la conclusion clinique et la nature des explorations éventuellement nécessaires, la mise à jour des données cliniques, para-cliniques et thérapeutiques.
    - La participation aux visites et contre-visites et la présentation des observations **;**
    - La participation aux activités de diagnostic et aux examens complémentaires : prélèvements biologiques, participation à des explorations fonctionnelles, endoscopies, actes médicaux de pratique courante, sous la surveillance des enseignants, la présence et éventuellement aider aux soins et aux interventions chirurgicales ;
    - La surveillance des malades, conjointement avec le personnel médical et paramédical
    - L'externe doit manifester son intérêt dans ce domaine en s'occupant des patients qui lui sont confiés, en les interrogeant, en tenant à

jours leurs dossiers médicaux et en prenant connaissance aussi des examens complémentaires.

4. Les gardes :

- Les externes sont assujettis aux gardes dans les services où ils sont affectés. Ces gardes sont fixées par le chef de service. Les stagiaires doivent participer aux gardes sous la responsabilité du médecin de garde pour une initiation progressive à la conduite du diagnostic et des premiers éléments d'orientation.

- Les malades qui ont posé des problèmes au cours de la garde ainsi que les entrants doivent être présentés au staff le lendemain en présence d'un sénior. La récupération après une garde n'est pas systématique. Elle est décidée en fonction des besoins du service et après avis du chef de secteur.

- Le nombre, l'horaire et les modalités de gardes sont fixés en fonction des services.

- Tout changement de garde doit être sous la responsabilité du chef de service.

5. Durée, date et horaire de stage :

- Les externes sont soumis au règlement interne des hôpitaux où ils sont affectés. Leur présence dans les services est obligatoire tous les jours.

- Le stage des externes débute de 8 h 30 mn à 12 H

- Durant les stages hospitaliers « temps plein », les étudiants doivent être présents du lundi au vendredi de 8h30 à 16h.

- Pour les stages hospitaliers « temps plein », une pause déjeuner de 45 minutes est accordée aux étudiants.

6. Le congé :

Les externes ont droit à un mois de congé par an (le mois d'août).

7. Les rémunérations :

Une indemnité de stage est octroyée par le Ministère de la santé au cours de l'externat et du stage interné.

8. Assiduité/Absence :

La présence et l'assiduité au cours des différents stages permettent aux étudiants de profiter au maximum de leur passage. Ainsi :

- Plus de deux absences non justifiées entraînent l'invalidation du stage.

- Deux retards excédant 15 minutes sont considérés comme une absence.

- Les absences pour maladie doivent être justifiées par un certificat médical homologué.

- Tout certificat médical (même homologué) excédant ou égale à 10% jours ouvrables de la durée de stage exposera à l'invalidation du stage.

- Des autorisations exceptionnelles d'absences pourront être accordées par le Doyen de la faculté de médecine après avis favorable du chef de service. Elles concernent :

    - Le décès de parents ou d'enfants : 3 jours

    - Le mariage : 2 jours, sous réserve de délivrer un acte de mariage actuel.

- Aucune autorisation d'absence n'est accordée pour la préparation des examens de la 2ème session. La faculté s'engage à envoyer les listes des étudiants passant l'examen de 2ème session et les dates durant lesquelles ils sont autorisés à s'absenter.

En dehors des cas sus cités, toute demande d'absence devra être accordée par le Doyen de la faculté de médecine après avis favorable du chef de service.

9. Respect de l'éthique :

- L'étudiant est impérativement tenu au secret professionnel. Toute violation dans ce domaine peut entraîner des sanctions notamment pénales.

- Il doit respecter le règlement intérieur de l'établissement.

- Il n'a pas le droit d'annoncer le diagnostic ni au patient ni à son entourage sauf s'il est accompagné d'un sénior.

- Il est tenu au respect de la vie et des droits du patient.

- Il doit entretenir des rapports de bonne confraternité avec les professionnels médicaux, paramédicaux et administratifs.

- Toute fraude ou falsification du carnet de stage expose l'étudiant à des sanctions graves

- Ne pas donner des renseignements médicaux par téléphone à une personne non identifiable.

10. Tenue vestimentaire et règles d'hygiène hospitalière :

- L'étudiant a l'obligation de respecter et de s'enquérir des consignes d'hygiène et de sécurité.
- Il a l'obligation de porter une tenue vestimentaire adaptée et propre :
    - Blouse médicale blanche propre dépassant les mi cuisses.
    - Chaussures silencieuses et propres.
    - Port obligatoire du badge.
    - Aspect soigné, hygiène corporelle correcte
    - Cheveux disciplinés et bien coiffés.
    - Ongles courts. Le vernis à ongles n'est pas autorisé.
    - Port des bijoux, sauf alliance, est interdit.

11. Aussi, l'étudiant doit :

- Respecter le plateau technique de stage ;
- Le patient sera identifié par son nom et pas par son numéro de chambre.
- La sortie du bâtiment n'est pas autorisée en tenue de travail
- La ponctualité est une priorité.
- Il est interdit d'utiliser un téléphone portable durant son service. Il est conseillé de mettre le portable en mode vibreur.
- Son attitude générale sera digne : il s'abstiendra de fumer, il évitera de s'asseoir sur les lits pendant les visites. Il évitera les conversations particulières entre étudiants, les réflexions ironiques lors des erreurs d'expression des malades ; il évitera également la familiarité excessive, le tutoiement condescendant.
- L'étudiant est tenu au secret médical vis-à-vis des tiers et même vis-à-vis des familles («ma langue taira les secrets qui me sont confiés» - Serment d'Hippocrate -)
- L'étudiant en formation aura une attitude positive de remise en question en cas de remarque formative. L'agressivité n'est pas admise.
- L'étudiant en stage respectera la répartition du travail et fera preuve d'un esprit d'équipe et d'entraide envers les autres soignants.
- L'étudiant en stage fera preuve d'une attitude favorable d'apprentissage

et de collaboration entre les étudiants de niveaux d'études différents ou d'établissements d'enseignement différents.

- L'étudiant en formation respectera le local ou l'armoire vestiaire mis à sa disposition. L'armoire et le local seront rendus propres à la fin du stage.
- Ne pas mâcher de chewing-gum pendant le service.

E. L'évaluation :

- L'évaluation des étudiants devra être faite avant le départ du stage.
- La validation doit être présentée à la Faculté de Médecine dans les délais fixés.
- La validation des stages d'externat se fera au cours d'une délibération, au plus tard une semaine après la fin du stage. Elle repose sur :
    - Le nombre d'absences
    - L'évaluation du comportement
    - La note de l'examen de fin de stage, sous forme d'évaluation pédagogique
    - Une note attribuée à la tenue, au contenu et à la qualité de l'observation médicale des patients dont l'externe est responsable.

F. Droits de l'étudiant :

- Le service hospitalier s'engage à Mettre à disposition de l'étudiant les moyens matériels nécessaires au bon déroulement de son stage.
- L'équipe pédagogique au sein du CHU s'engage à:
    - Assurer une formation de qualité qui répond aux objectifs prédéfinis du stage.
    - Développer les capacités de raisonnement clinique et de synthèse de l'étudiant.
    - Bien définir les tâches de l'étudiant dans le cadre de l'activité hospitalière.
- A la fin de chaque stage, les étudiants sont invités à formuler une appréciation de la qualité du stage en remplissant un formulaire anonyme élaboré par le comité se stage.

Annexe 2: Situations d'encadrement

Consultation : C'est un ensemble de situations professionnelles auxquelles le stagiaire est confronté dans le cadre de la démarche diagnostique et thérapeutique.

Réunion du staff et de service : est une rencontre régulièrement planifiée réunissant encadreurs et encadrés dans le but de discuter de cas cliniques du service. Le stagiaire est invité à expliciter sa démarche clinique.

La réunion de service est un cadre d'échange regroupant toutes les catégories professionnelles du service pour un bon fonctionnement administratif et technique.

Garde et permanence : C'est un processus de surveillance et de prise en charge du malade en dehors des heures structurées du travail. Elle vise à garantir la continuité des soins.

Tour de salle : Est un processus dans lequel un apprenant fait une évaluation régulière du malade, prend les signes subjectifs et objectifs, fait ses appréciations en rapport avec l'évolution clinique du malade et donne des propositions en rapport avec la prise en charge instaurée.

Bloc opératoire : Est un ensemble des situations professionnelles auxquelles l'apprenant devra être exposé. Ces situations se réalisent dans un cadre spécifique incluant notamment les locaux et les équipements nécessaires aux opérations chirurgicales dans le strict respect des principes d'asepsie et de l'antisepsie.

Explorations para-cliniques :

Ensemble d'analyses complémentaires à l'examen et auxquelles le stagiaire est invité à participer dans le but d'affiner ses aptitudes à mener une démarche clinique. Ces analyses comprennent l'imagerie médicale, l'endoscopie et le laboratoire biomédical.

Audit :

Analyse approfondie des informations recueillies des documents ou de situations-problèmes visant à documenter les bonnes pratiques et/ou à améliorer la qualité des prestations. Il est clinique, c'est-à-dire qu'il porte sur le dossier d'un patient donné et, de manière systématique, sur le décès.

Annexe3:Référentiel du stage hospitalier

Préambule :

Le stage hospitalier constitue une étape importante dans la formation de l'étudiant en médecine, au cours duquel il acquiert des compétences pratiques nécessaires à sa future fonction de médecin de famille.

Mais comme ce stage ne s'improvise pas, il est nécessaire d'une part d'organiser, de gérer et de formaliser les activités d'apprentissage et d'autre part d'évaluer l'acquisition des compétences dans les services hospitaliers. Ainsi, le référent du stage sous l'égide de son chef de service et en collaboration avec les autres encadreurs de l'équipe joue un rôle important pour assurer le bon déroulement du stage.

Il constitue donc l'interlocuteur de l'étudiant par rapport au reste du corps enseignant du service, et constitue aussi l'interlocuteur du service qu'il représente par rapport au décanat.

Ce référentiel codifie le rôle du réfèrent du stage de chaque service et délimite ses actions.

I- **Présentation du référent du stage :**

Le référent du stage est un enseignant proposé par le chef du service et désigné par le doyen de la faculté de médecine et de pharmacie. Il assure sous l'égide du chef du service et en collaboration avec les membres de l'équipe, l'organisation, la gestion et la formalisation des activités d'apprentissage de l'étudiant au cours de son stage hospitalier, ainsi que l'évaluation de ses compétences acquises.

Le rôle du référent du stage se concrétise ainsi à trois niveaux :

- Vis-à-vis des membres de l'équipe.
- Vis-à-vis des étudiants.
- Vis-à-vis du décanat.

II- **Rôle du référent du stage vis-à-vis des enseignants du service :**

Le référent du stage hospitalier doit préparer à l'avance l'accueil des étudiants et leur passage au sein du service.

Le corps des enseignants doit valider les règles du fonctionnement du service auxquelles l'étudiant doit adhérer, ainsi que les activités de soins où il va être impliqué.

Pour cela, il doit coordonner au préalable avec les enseignants du service pour :

A- **Établir l'organigramme du stage :**

a. Etablissement d'un registre de présence avec les horaires d'arrivée et de départ que l'étudiant doit signer chaque jour au secrétariat.

b. Planification des séances d'apprentissage qui vont être assurées par l'enseignant et/ou par le résident **(**Fiche N°1) :

- La répartition sur les jours
- L'enseignant et/ou le résident qui va assurer la formation et valider l'objectif.
- La méthode d'enseignement à utiliser :
  - Séances d'ARC +++ précédées d'un test de pré requis relatif à l'affection traitée si dossier connu et au motif de consultation si dossier non connu
  - Simulation, démonstration de techniques : interrogatoire, examen clinique, gestes
  - Séances d'interprétation d'examens complémentaires
  - Jeux de rôle pour l'apprentissage des attitudes

c. Répartition des étudiants avec rotation par secteur d'apprentissage : salles d'hospitalisation, consultation, HDJ, salles de soins, salles de plâtre, unités de diététique, unités d'exploration, blocs opératoires, urgences (Fiche N°2).

d. Planification des gardes.

B- **Préciser les modalités de l'évaluation formative continue et sa rythmicité :**

a. Vérification des carnets de stage de façon régulière

b. Vérification de l'acquisition des compétences pratiques

c. Correction des observations médicales rédigées par les étudiants dans les salles d›hospitalisation, durant les consultations ou durant les gardes

C- **Coordonner avec les membres de l'équipe pour préparer l'évaluation finale :**

a. Choisir la méthode d'évaluation : ECOS

b. Préparer la banque des questions,

c. Préparer les stations : Local, responsable de chaque station…….

III- Rôle du réfèrent du stage vis-à-vis des étudiants :

A- Accueillir les étudiants et présenter :

a. Les locaux du service, le corps médical et le corps paramédical.

b. Les objectifs du stage détaillés dans le carnet du stage.

c. Le règlement intérieur du service : horaires, badge, blouse, ...

d. L'organisation générale du service ainsi que ses différentes activités.

B- Désigner un représentant du groupe.

C- Expliquer le déroulement du stage en fonction de l'organigramme préétabli (Fiche N°3):

a. Explication des taches générales à réaliser par chaque étudiant : assister à la visite et au staff, entretien des dossiers.

b. Répartition sur les différentes activités de soins réalisés au service : consultation, éducation thérapeutique, HDJ, garde.....

c. Planning des séances d'apprentissage selon les objectifs et la méthode d'enseignement à utiliser

D- Afficher l'organigramme du stage : Répartition, planning, gardes, séances d'ARC..

E- Expliquer aux étudiants comment utiliser le carnet de stage :

a. Avoir le carnet de stage en permanence sur soi y compris durant les gardes

b. Validation régulière de chaque objectif par les personnes ressources de l'apprentissage

F- Veiller régulièrement au cours du stage, avec l'aide du chef de service, au respect de l'application de l'organigramme

G- Vérifier en collaboration avec les autres enseignants et sous la supervision du chef de service, la réalisation de l'évaluation formative continue :

a. Vérification régulière des carnets de stage

b. Vérification de l'acquisition des compétences pratiques

c. Vérification de la correction des observations rédigées par les étudiants...

H- Recevoir les suggestions et propositions des étudiants :

Le représentant du groupe peut exposer les problèmes des étudiants ; permissions, difficultés, suggestions….

I- Évaluation :

a. Participer avec le chef de service et l'ensemble des collègues à la préparation des évaluations par ECOS

b. Informer les étudiants du jour de l'évaluation, méthode d'évaluation (ECOS), modalité d'évaluation, déroulement…

IV- Rôle du référent du stage vis-à-vis du décanat :

A. Remplir la fiche de validation du stage

B. Veiller sur l'envoi d'une copie au responsable du stage par courriel et par mail.

C. Assister à la réunion de validation du stage

D. Exposer les éventuels problèmes rencontrés au cours du stage

E. Présenter les besoins nécessaires bon le bon fonctionnement et déroulement du stage.

Fiche N°1 : Exemple de planning des séances d'apprentissage

Objectif	Enseignant	Date	Méthode

Fiche N°2 : Exemple de répartition des étudiants sur les activités de soins

Date	Consultation	Hop du jour	Exploration	Éducation thérapeutique
J1	Groupe 1	Groupe 2	Groupe 3	Groupe 4
J2	Groupe 5	Groupe 6	Groupe 7	Groupe 8
J3				

Fiche N° 3 : Exemple de planning général

	8h30 à 9h 30	10h à 11h00	11 h à 12h
Lundi	Préparation des observations	Visite	Activité de soins
Mardi	Visite	Séance d'apprentissage	Activité de soins
Mercredi	Préparation des dossiers	Visite	Activité de soins
Jeudi	Visite	Séance d'apprentissage	Activité de soins
Vendredi	Staff	Activité de soins	Activité de soins

MARRAKECH

جامعة القاضي عياض

UNIVERSITÉ CADI AYYAD

كليـــــــة الـطب
و الصيدلة - مراكش

FACULTÉ DE MÉDECINE
ET DE PHARMACIE - MARRAKECH

Sidi Abaad -Assif,B .P 7010,
40000 Marrakech
Tél.: +212 5 24 33 98 98
Fax.: +212 5 24 43 28 87
Site web Faculté : www.fmpm.ucam.ac.ma
Site web Université : www.uca.ma